

病例规模的推断收益边界： 估计目标、监测杠杆与流感住院实证

(匿名评审稿)

2026 年 10 月 9 日

摘要

准确识别疫情增长并预测短期病例负担是现代传染病预警与应急响应的核心任务。常规直觉认为样本量越大推断精度越高，但在个体超传播、监测漏报与共同环境扰动并存时，“样本量”与“信息量”不能简单等同。既有信息下界的标度律建立在当期再生数 R_t 一类估计目标上；本文证明更换估计目标后标度律随之改变，据此将“病例规模何时不再是主要推断瓶颈”作为监测设计问题严格推导。主要结果：(i) 在已知风险集 n 、报告率 ρ 与离散参数 k 的基准模型下，矩估计量 $\hat{R}_t = C_t/(\rho n)$ 为条件 MLE 且达到 Fisher 信息逆，方差随期望报告规模 $m = \rho n$ 单调收敛于零；(ii) 以该估计量在单期设计下推断跨期基础水平 $\bar{R}$ 时，方差受环境底板 v_R 制约，导出两项相等的平滑交叉点 $m_\times$ ；(iii) 提高报告率 ρ 仅消除漏报抽稀方差，唯有扩大基数 n 使各项方差同时衰减，多期预算设计下拉长期数以 $O(1/T)$ 削减环境方差；(iv) 给出负二项单调似然比的精确增长判定检验与离散功效，并剥离事后增长统计量与事前单步预测的代数关系。实证方面，利用全美 CDC NHSN 2020–2026 年 16,218 个州周流感住院数据：流行初期仿射 FGLS 拟合得经验交叉点约为 22.6 例/周（规模项斜率 $b = 2.2434$ 显著为正，截距 $a = 0.0991$ 为与规模无关经验损失截距；该值在不同规格下呈现 10.6–42.7 的分布跨度，需注意周捕获规模 D_t 与理论 m 存在维度映射差异）；误差预算分解表明与规模无关份额占 39%–55%（回顾口径三成分 54.6% / 二成分 54.8%），大规模观测（ $D_t \geq 250$ ）误差降至全体平均的约六成；达峰期近 89% 总体误差来自平稳基准偏移，控制偏移后规模项依然有效（两阶段斜率差异未达统计显著）；时变交叉点在流感季（中位数 19.7–20.4）与非流感季（46.9–47.9）系统性分异。上述定量参照为监测资源在扩大捕获、多期平滑与引入环境协变量之间的优化配置提供了分析判据。

关键词：疫情增长判定；分支过程；超传播；漏报；环境随机性；监测设计；短期预测；预测误差分解；流感住院实证

The Inferential Return Boundary of Case Counts: Estimation Targets, Monitoring Levers, and Influenza Hospitalization Evidence

1 引言

准确识别疫情由平稳或下降转为上升增长，并对随后数周的病例负担作出可靠预测，是现代传染病预警与公共卫生应急响应的核心支柱。在常规统计直觉中，大样本量通常意味着高推断精

度，即增加捕获病例数能够持续压制随机计数波动的相对影响。然而，在传染病监测与动力学建模的真实场景下，这一直觉往往遭遇严峻挑战：病原体传播普遍具有高度个体异质性（超传播），导致继发感染数严重过离散 [1, 2]；监测系统普遍存在不同程度的不完全检测与报告延迟 [3, 4]；此外，处于同一地理辖区或时间窗口内的宿主群体共同受到气象条件、人群接触模式以及周期性社会流动等环境随机扰动 [5, 6]。在个体微观超传播、宏观监测漏报与中观共同环境波动交织并存的条件下，“样本量”与“信息量”不能再被简单等同。

关于传染病监测数据中信息瓶颈与推断局限的研究，在既有文献中形成了数条清晰而深入的发展脉络。第一条脉络源于对**传播异质性与更新过程动力学**的建模探索。开创性工作揭示了个体繁殖数高度偏离泊松假设的负二项分布特征，阐明了传统均值推断严重低估爆发概率与灭绝风险的机制 [1, 7]。随后，基于发病时间间隔分布的代际更新过程模型逐步确立了时变再生数推断的通用范式 [8, 9]，其中以 Cori et al. [10] 提出的瞬时更新框架及其衍生工具（如 EpiEstim）成为实时疫情追踪的国际主流基准。近年来，学者们进一步针对滑动窗口选择、世代间隔不确定性及截断偏差对再生数估计的扭曲效应展开了深入的方法学讨论与评估指南 [11–13]。

第二条脉络聚焦于**不完全观测、报告延迟与状态空间滤波**。现实公共卫生系统难以直接捕捉真实感染发生，往往只能观测到夹杂抽稀与迟滞的医院确诊或重症入院序列 [3, 14]。为了从带噪监测序列中恢复潜在未观测感染压力，学者们构建了包含粒子滤波、半机制更新过程与分层时空平滑在内的状态空间推断架构 [4, 15]。特别地，针对显著漏报疾病的计数建模，Bracher and Held [16] 提出了基于边缘矩匹配的方法，在避免高维潜变量完整似然计算的同时，系统揭示了报告率与传播强度的联合可识别性边界。

第三条脉络近年来利用**信息论与 Fisher 信息量**严格解析了带噪疫情曲线所蕴含的物理信息极限。开创性文献量化了带噪发病序列中的 Fisher 信息量随观测期与抽样比例的演化规律 [17]，进而确立了在有效再生数框架下实时检测疫情反弹的严格信息论下界 [18]，并揭示了由观测噪声诱导的非对称干预延迟边界 [19]。然而，既有信息下界文献所确立的标度律（Scaling Law）及其信息量随期望病例数近似线性增长的结论，主要是建立在**当期再生数 R_t 或特定瞬时传播强度**这一类估计目标之上的。本文与之形成理论对话：**当推断目标由当期参数转换为跨期基础水平时，方差对病例规模的标度响应出现结构性分水岭**——对当期瞬态参数 R_t ，增加病例规模的边际方差收益恒为正，测量方差随规模扩大严格单调趋零（命题 1）；而对跨期平稳的潜在基础趋势 $\bar{R}$ ，单期推断必然留存不可消除的环境方差底板 v_R ，由此定义出两类方差相等的经验收益拐点 $m_\times$ （命题 2）。换言之，“病例数何时不再是主要瓶颈”不是疫情系统的孤立静态属性，而是**估计目标与观测维度的内生属性**，这一目标依赖性为既有信息极限理论补充了一个关键的结构维度。

第四条脉络植根于非线性生态动力学中**人口统计随机性 (Demographic Stochasticity)**与**环境随机性 (Environmental Stochasticity)**的经典二分法 [20–22]。群体微观的繁殖与抽稀随机性随种群或样本规模扩大而呈现大数定律衰减，但不可观测的宏观共同环境震荡在单期横截面内具有共同加性或乘性特征，无法仅凭该期样本内部的数据聚合予以消除 [5, 6, 23]。类似地，从应用统计与计量学的视角来看，这一问题与经典**测量误差模型 (Measurement Error Models)**与**混合效应信度理论**在方差分解的代数形式上高度一致 [24–26]。在流行病学暴露与风险估计中，观测噪声导致的衰减偏倚与方差分配已被广泛探讨 [27]。在这一语境下，本文推导的方差交叉点 $m_\times$ ，在方差分解的代数形式上恰对应单期估计方差内部信度比（Reliability Ratio，即信号方差占总方差的比例）等于 0.5 的对称位置 [25]。

第五条脉络来自于**大规模真实监测网络与流感预测评估实践**（如 CDC FluSight 挑战赛）

的经验启示 [28–31]。全美疾控中心长期运行的多模型前瞻性集成预测评估表明，随着监测系统覆盖面的扩张与统计模型的复杂化，前瞻预测精度的提升迅速呈现收益递减平台，多模型集合预警在流行拐点与传播态势突变处往往面临显著的预测偏差与区间覆盖不稳定（COVID-19 多模型预测中心的评估亦显示类似现象）[32, 33]；在评估此类前瞻预测表现时，相对尺度均方误差等评分规则展现出有效平衡不同发病规模量级的稳健优势 [34]。而在历史住院基准方面，Zhou et al. [35] 针对全美流感住院负担的基础流行病学测算，为本文折算每例有症状感染的住院比例提供了核心参考。

面对上述理论进展与现实经验，回答“病例规模何时不再主导推断误差”，需要超越单代理想公式的无条件外推。本文的贡献**不在于单独提出新的负二项分支模型或漏报校正公式**，而在于针对“病例规模何时不再主导推断误差”这一具体监测设计问题，建立一个分层随机推断框架，系统实现以下五项贡献：

- (1) **明确估计目标与收益拐点**：严格区分当期瞬态传播参数 R_t 与跨期潜在基准 $\bar{R}$ ，证明二者对增加病例规模的边际方差响应截然不同；解析导出单期估计方差内部环境地板项与抽样方差项相等的收益拐点 $m_\times$ （对应信度比 0.5 的临界结构位置）。
- (2) **精确拆解监测杠杆的非对称性**：证明“扩大真实感染捕获基数 n （人群/地理覆盖扩大）”与“提高检测报告率 ρ ”存在数理非对称性——显式分解指出提高报告率仅能消除漏报抽稀方差 $\frac{(1-\rho)\bar{R}}{\rho n}$ ，无法消除完全报告时依然存在的计数方差与超传播内在抽样方差；唯有扩大真实基数 n 才能使各项方差同时衰减。
- (3) **分析理想设计下的监测维度权衡**：在理想化重复采样设计与总监测输入规模预算 $B = T \cdot m$ 约束下，严格推导拉长独立观测期数 T 削减环境方差 v_R 的精确表达式与 AR(1) 自相关闭式，并明确指出每期整数风险集约束下的离散可行设计集合。
- (4) **给出增长判定检验与预测基准评估**：导出基于负二项单调似然比的精确上尾超临界增长判定检验并证明其水平控制；在时间序列更新过程中清晰界定事后代理增长统计量与事前单步病例预测的内在代数关系与条件方差展开，并通过有限样本模拟检验理论基准的适用性与衰减形态。
- (5) **真实监测数据实证与误差预算分解**：采用美国疾控中心国家医疗保健安全网（CDC NHSN）2020–2026 年覆盖 50 个州及华盛顿特区周度流感住院真实数据（16,218 个州周观测），在控制聚类不确定性的前提下，测得经验收益放缓平台的数量级与报告政策切换前后的离散度分化，识别出达峰期失效的是跨期平稳基准假定而非病例规模本身；进一步构建与 Cori 时变更新过程基线的竞争对照，开展预测偏差项分解与季节内独立两阶段最小二乘（2SLS）稳健性检验；并给出误差预算份额分解与时变经验交叉点：仿射拟合中约四至五成半（39%–55%）的误差份额落在与规模无关的拟合项上，样本中已实现的大规模观测误差约为全体平均的六成——这一份额结构本身，提示进一步评估环境协变量与多期信息的价值。

本文结构安排如下：第 2 节建立传播与报告模型并界定两类估计目标；第 3 节呈现核心理论结果、交叉点与监测杠杆非对称性推导；第 4 节报告增长判定离散功效与更新过程预测模拟；第 5 节利用全美流感住院真实监测数据展开系统实证检验与反证边界分析；第 6 节总结全文并探讨公共卫生监测设计的决策启示。

2 模型与估计目标

2.1 传播与报告模型

设上一传播代有 n 名真实感染者，第 i 名感染者产生的继发感染数为 $X_{i,t}$ 。在给定当期环境条件下的传播参数 R_t 后，假设个体继发感染数服从过离散负二项分支分布：

$$\mathbb{E}[X_{i,t} | R_t] = R_t, \quad \text{Var}(X_{i,t} | R_t) = R_t + \frac{R_t^2}{k}, \quad (1)$$

其中 $k > 0$ 为个体传播离散参数 ($k \rightarrow 0$ 对应极端超传播, $k \rightarrow \infty$ 退化为泊松分布)。假设在给定 (n, R_t) 条件下，个体继发感染数 $\{X_{i,t}\}_{i=1}^n$ 相互条件独立。当期真实新发感染总数为 $I_t = \sum_{i=1}^n X_{i,t}$ 。

观测过程采用固定报告率 $\rho \in (0, 1]$ 的基准二项抽稀模型：

$$C_t | I_t \sim \text{Binomial}(I_t, \rho). \quad (2)$$

理论基准设定：第 3 节的推导在已知真实风险集规模 n 的条件下建立理论基准，使各类方差分量的机制来源获得解析透明的对照参照系；第 3.7 节进一步给出仅报告数据可见时的条件预测方差分解，并说明单代基准不能直接移用。

2.2 两种不同的估计目标

在推导方差前，必须严格区分两类性质迥异的估计目标：

- **目标 A (当期传播参数)：**估计给定当期环境条件下的传播参数 R_t 。目标是测量当期环境（包含当周气象、人群接触模式等共同扰动）所决定的个体期望继发感染水平。注意：该参数不同于最终实现的感染比例 I_t/n ，后者还叠加了个体分支过程的抽样随机性。
- **目标 B (跨期基础水平)：**估计消除单周共同随机扰动后的潜在基础增长趋势 $\bar{R}$ 。

在单期基准设计中，给定风险集规模 n 后，假定当期环境满足条件矩设定：

$$\mathbb{E}[R_t | n] = \bar{R}, \quad \text{Var}(R_t | n) = v_R > 0. \quad (3)$$

这一条件可由固定试验设计的 n ，或 R_t 与 n 相互独立作为充分条件予以保证。

2.3 预测信息集

针对预测问题，其表现依赖于当前可用的信息集。本文严格区分两种信息集：

- **全历史信息集 $\mathcal{F}_t^I$ ：** $\mathcal{F}_t^I = \sigma(I_1, \dots, I_t, C_1, \dots, C_t)$ 。在此理想信息集下，截至第 t 期的历史真实感染完全可知，未来的感染压力 Λ_{t+1} 是已确定的历史量。
- **仅报告序列信息集 $\mathcal{F}_t^C$ ：** $\mathcal{F}_t^C = \sigma(C_1, C_2, \dots, C_t)$ 。这是现实监测中唯一可直接获取的信息，满足 $\mathcal{F}_t^C \subset \mathcal{F}_t^I$ 。由于二项漏报的存在， $I_1, \dots, I_t$ 未被完全观测，下一周的潜在感染压力 Λ_{t+1} 本身具有不确定性，成为随机变量。

3 理论结果

3.1 当期传播参数、Fisher 信息与条件方差

命题 1 (当期传播参数的条件似然、Fisher 信息与方差). 在个体继发感染条件独立且服从负二项模型 (1)、二项报告率 ρ 固定的基准条件下, 当真实风险集 n 与报告率 ρ 已知时:

(i) 报告病例数 C_t 在给定 (n, R_t) 下的边缘分布严格服从负二项分布:

$$C_t | n, R_t \sim \text{NB}(\text{均值} = \rho n R_t, \text{形状参数} = nk); \quad (4)$$

(ii) 矩估计量 $\hat{R}_t = \frac{C_t}{\rho n}$ 恰为该条件似然模型下 R_t 的极大似然估计量 (MLE); 当观测值 $C_t = 0$ 时, $\hat{R}_t = 0$ 位于非负参数空间的边界;

(iii) 在内部参数点 $R_t \in (0, \infty)$ 上, 该模型关于 R_t 的 Fisher 信息量为:

$$\mathcal{I}(R_t | n) = \frac{n}{\frac{R_t}{\rho} + \frac{R_t^2}{k}}; \quad (5)$$

(iv) 在内部参数空间 $R_t \in (0, \infty)$ 上, 估计量 $\hat{R}_t$ 的条件方差严格达到 Cramér-Rao 下界:

$$\text{Var}\left(\frac{C_t}{\rho n} \middle| n, R_t\right) = \mathcal{I}(R_t | n)^{-1} = \frac{R_t}{\rho n} + \frac{R_t^2}{kn}. \quad (6)$$

证明. 由负二项分布的概率生成函数 (PGF), 若个体继发感染数 $X_{i,t} \sim \text{NB}(k, p)$, 其中 $p = \frac{k}{k+R_t}$, 则 $I_t = \sum_{i=1}^n X_{i,t} \sim \text{NB}(nk, p)$, 其 PGF 为 $G_{I_t}(s) = \left(\frac{p}{1-(1-p)s}\right)^{nk}$. 在二项抽样 $C_t | I_t \sim \text{Binomial}(I_t, \rho)$ 下, 复合分布的 PGF 为:

$$G_{C_t}(s) = G_{I_t}(1 - \rho + \rho s) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)(1 - \rho + \rho s)}\right)^{nk} = \left(\frac{p^*}{1 - (1-p^*)s}\right)^{nk},$$

其中 $p^* = \frac{p}{p + \rho(1-p)} = \frac{k}{k + \rho R_t}$. 这证明了 $C_t | n, R_t$ 服从形状参数为 nk 、成功概率为 p^* 的负二项分布, 条件均值为 $\rho n R_t$.

其对数似然函数为:

$$\ln L(R_t) = \text{const} - (nk + C_t) \ln(k + \rho R_t) + C_t \ln R_t.$$

对 R_t 求导并令得分为零:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial R_t} = -\frac{\rho(nk + C_t)}{k + \rho R_t} + \frac{C_t}{R_t} = \frac{k(C_t - \rho n R_t)}{R_t(k + \rho R_t)} = 0 \implies \hat{R}_t^{\text{MLE}} = \frac{C_t}{\rho n}.$$

计算得分函数的方差以求 Fisher 信息量:

$$\mathcal{I}(R_t | n) = \text{Var}\left(\frac{\partial \ln L}{\partial R_t}\right) = \frac{k^2 \text{Var}(C_t | n, R_t)}{R_t^2(k + \rho R_t)^2}.$$

代入负二项方差 $\text{Var}(C_t | n, R_t) = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n R_t^2}{k} = \frac{\rho n R_t(k + \rho R_t)}{k}$:

$$\mathcal{I}(R_t | n) = \frac{k^2 \cdot \frac{\rho n R_t(k + \rho R_t)}{k}}{R_t^2(k + \rho R_t)^2} = \frac{k \rho n R_t}{R_t^2(k + \rho R_t)} = \frac{n}{\frac{R_t}{\rho} + \frac{R_t^2}{k}}.$$

因此其倒数恰为 $\text{Var}(\hat{R}_t | n, R_t) = \frac{R_t}{\rho n} + \frac{R_t^2}{kn}$. □

注记 1 (泊松极限退化与边界限定). 命题 1 阐明了微观异质性与不完全报告下 *Fisher* 信息量对病例规模的响应机制。特别地，当个体超传播离散参数 $k \rightarrow \infty$ (个体繁殖退化为无异质性的经典泊松分布) 时，*Fisher* 信息量精确退化为 $\mathcal{I}(R_t | n) = \frac{\rho n}{\bar{R}_t}$ ，与泊松更新过程中的经典标度律 [17] 严格一致；而在现实存在超传播 (有限 k) 时，分母出现的 R_t^2/k 项显式刻画了个体繁殖异质性带来的信息衰减惩罚。需明确指出：该结论是在已知风险集与报告率、且估计当期瞬时参数 R_t 的基准结果，不能直接推演至仅凭报告数据推断跨期基础水平 $\bar{R}$ 的情境。

3.2 跨期基础水平的单期边际方差

命题 2 (跨期基础水平的单期边际方差). 在条件矩假设 (3) 下，若使用单期估计量 $\frac{C_t}{\rho n}$ 估计跨期基础水平 $\bar{R}$ ，其给定风险集 n 的条件边际方差为：

$$\text{Var}\left(\frac{C_t}{\rho n} \middle| n\right) = v_R + \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{\bar{R}^2 + v_R}{kn}. \quad (7)$$

证明. 应用全方差公式以 $\bar{R}$ 为目标分解：

$$\text{Var}\left(\frac{C_t}{\rho n} \middle| n\right) = \text{Var}\left(\mathbb{E}\left[\frac{C_t}{\rho n} \middle| n, R_t\right] \middle| n\right) + \mathbb{E}\left[\text{Var}\left(\frac{C_t}{\rho n} \middle| n, R_t\right) \middle| n\right].$$

由命题 1，第一项为 $\text{Var}(R_t | n) = v_R$ 。第二项为：

$$\mathbb{E}\left[\frac{R_t}{\rho n} + \frac{R_t^2}{kn} \middle| n\right] = \frac{\mathbb{E}[R_t | n]}{\rho n} + \frac{\mathbb{E}[R_t^2 | n]}{kn}.$$

利用条件二阶矩关系 $\mathbb{E}[R_t^2 | n] = \text{Var}(R_t | n) + (\mathbb{E}[R_t | n])^2 = v_R + \bar{R}^2$ ，相加即得式 (7)。 $\square$

注记 2 (生态随机性传承与单期方差底板). 式 (7) 呈现的 $v_R + A/m$ 方差结构，在数理思想上与生态动力学中人均增长率方差的经典二分 (即环境方差底板与按 $1/N$ 衰减的人口统计方差，20) 一脉相承，并与传染病宏观时序模型中环境噪声无法被种群聚合消除的实证结论相容 [22]。本文的贡献在于将这一分解形式引入二项报告抽稀与超传播分支动力学，解析阐明了抽稀与个体异质性对尺度项 A 的微观构成。需指出：该底板限于指定单期估计量且无外部协变量的情境，并不排斥引入气象行为协变量或多期滤波进一步降低方差；它界定了仅凭单期横截面数据聚合无法消除的共同随机性下限。

3.3 方差占比交叉点 $m_\times$

令 $m = \rho n$ 为上一代真实风险集对应的期望被报告人数 (当期新发报告数的条件期望为 $\rho n R_t$ ，两者在 R_t 波动下不等；图注与政策讨论中的“期望报告病例数”均取本定义)。式 (7) 可重写为 $v_R + A/m$ ，其中

$$A = \bar{R} + \frac{\rho(\bar{R}^2 + v_R)}{k}. \quad (8)$$

本文称 A/m 为病例规模相关方差项。

定义 1 (方差占比交叉点). 当 $v_R > 0$ 时，在基础水平单期估计方差式 (7) 内部，病例规模相关方差项 A/m 与共同环境方差项 v_R 相等的期望报告病例规模定义为方差占比交叉点：

$$m_\times \triangleq \frac{A}{v_R} = \frac{\bar{R} + \rho(\bar{R}^2 + v_R)/k}{v_R}. \quad (9)$$

经济学与监测含义： $m_{\times}$ 的解释是“在给定 $(\rho, k, \bar{R}, v_R)$ 下，沿扩大 n 方向时两类方差相等的规模”。在 $m = m_{\times}$ 处，总方差中两项各占 50%。导数 $\frac{dV}{dm} = -\frac{A}{m^2}$ 在 $m_{\times}$ 处平滑连续，不存在突变。当 $m > m_{\times}$ 时，环境方差占主导，增加病例数仍能降低方差，但仅能作用于占比逐渐减小的 A/m 项。

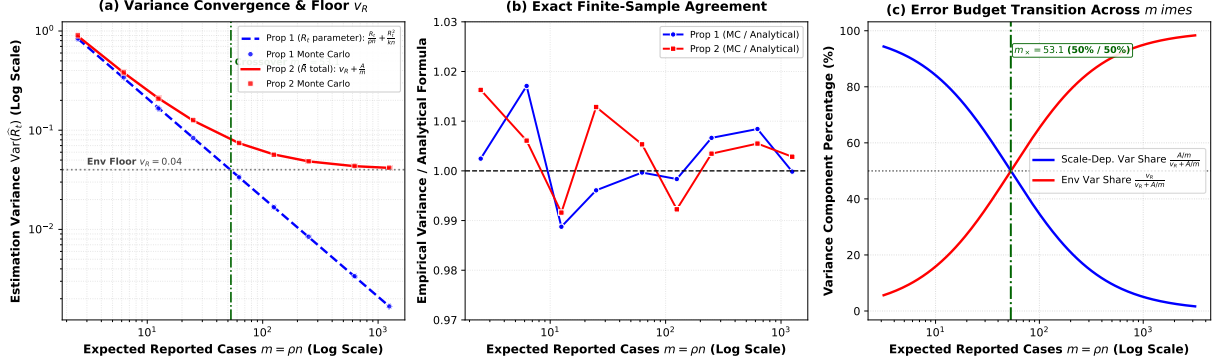


图 1: 理论渐近方差、环境随机性底板与边际收益衰减的蒙特卡洛验证。(a) 瞬时再生数 R_t 条件测量方差式 (6) (蓝) 与跨期水平 $\bar{R}$ 方差式 (7) (红) 随期望报告规模 $m = \rho n$ 的双对数衰减曲线。瞬时方差严格趋零，而跨期方差平稳收敛至环境随机性底板 $v_R = 0.04$ 。(b) 经验仿真方差与理论闭式解析解之比在全部参数网格下处于 0.988–1.017 之间，验证了有限样本下 Cramér–Rao 下界的代数紧致性。(c) 误差预算动态演变：在收益拐点 $m_{\times} = 53.1$ 处，规模相关项与环境随机性恰好各占 50%，展现了误差主导机制的平滑交接。模拟基于 50,000 次独立重复试验，参数基准设定为 $\bar{R} = 1.15, v_R = 0.04, k = 0.35, \rho = 0.25$ 。

3.4 监测杠杆的非对称性：样本基数 n 与报告率 ρ 的精确拆解

在公共卫生监测实践中，增加报告病例数 $m = \rho n$ 存在两条截然不同的政策路径：其一是**扩大监测捕获基数 n** （如扩大哨点覆盖范围、汇总跨区域感染者）；其二是**提高报告率 ρ** （如加强密切接触者筛查、降低就医检测门槛）。本文将式 (7) 明确拆解为关于 (n, ρ) 的二元函数：

$$V(n, \rho) = v_R + \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{\bar{R}^2 + v_R}{kn}. \quad (10)$$

为彻底理清报告率 ρ 的作用机制，将第二项恒等拆解为：

$$\frac{\bar{R}}{\rho n} = \underbrace{\frac{\bar{R}}{n}}_{\text{完全报告时仍有的计数波动}} + \underbrace{\frac{(1-\rho)\bar{R}}{\rho n}}_{\text{漏报额外引入的抽稀方差}}. \quad (11)$$

命题 3 (监测杠杆的非对称性与超传播方差下界). 在单期观测设计下，扩大基数 n 与提高报告率 ρ 对估计方差的削减效应存在本质非对称性：

- (i) **报告率杠杆的饱和和下界：** 给定任意有限风险集规模 $n < \infty$ ，当报告率趋于理想极限 ($\rho \rightarrow 1$ ，即完全无漏报监测) 时，漏报额外抽稀方差项 $\frac{(1-\rho)\bar{R}}{\rho n} \rightarrow 0$ ，但估计方差存在严格大于环境底板的固有下界：

$$\lim_{\rho \rightarrow 1} V(n, \rho) = v_R + \frac{\bar{R}}{n} + \frac{\bar{R}^2 + v_R}{kn} > v_R. \quad (12)$$

提高报告率消除的是漏报额外引入的抽稀方差，无法消除完全报告时依然存在的计数波动 $\frac{\bar{R}}{n}$ ，更无法消除由个体超传播 (k) 引起的内在子代抽样随机性 $\frac{\bar{R}^2 + v_R}{kn}$ ；

(ii) **样本基数杠杆的全域收敛性**: 无论报告率 $\rho \in (0, 1]$ 处于何种水平, 只要扩大真实风险集规模至极限 ($n \rightarrow \infty$), 两项病例规模相关方差均严格收敛于零:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(n, \rho) = v_R. \quad (13)$$

证明. 将式 (11) 代入式 (10) 分别令 $\rho \rightarrow 1$ 与 $n \rightarrow \infty$, 代入极限直接即得。□

注记 3 (公共卫生监测资源配置启示与适用边界). 命题 3 揭示了监测杠杆的数理不对称性: 在小风险集且个体传播高度离散时, 单纯提高报告率无法消除个体传播抽样波动。然而, **该数理极限并不直接等同于现实中的绝对政策配置排序**。在实际流行病学监测决策中, 跨区域汇总扩大 n 可能会引入不同地理区域间传播参数 R_t 、超传播 k 和环境扰动的空间异质性; 同时, 扩大哨点覆盖与提升就医检测率的边际实施成本与数据延迟各不相同。因此, 决策者应将该命题作为理解噪声结构构成的理论参照, 结合具体干预的可行性与成本展开综合评估。

3.5 理想设计下的监测维度权衡: 单期规模 vs 跨期跨度

进一步探讨监测资源分配的理论边界。考虑如下**理想化重复采样设计**: 设设计者在 T 个观测期内设定相同的每期真实风险集规模 $n_T = B/(\rho T)$, 记为设计方案 $D_T = (T, n_T)$; 跨期基础水平 $\bar{R}$ 、报告率 ρ 、个体离散参数 k 与环境方差 v_R 保持不变。给定完整环境扰动序列后, 各期继发分支与报告抽样过程条件独立, 且条件均值均为零。

基于设计 D_T 的 T 期观测数据, 估计跨期基础水平 $\bar{R}$ 的样本均值估计量定义为:

$$\bar{\hat{R}}_T \triangleq \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{R}_t = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{\rho n_T}. \quad (14)$$

命题 4 (预算约束下的监测设计权衡与可行性集合). 在上述理想化重复采样设计下, 若总监测输入规模 (各期期望被报告风险集人数之和) 受限为 $B = T \cdot m$ (其中 $m = \rho n_T$ 为每期上一代风险集对应的期望被报告人数, 见第 3.3 节):

(i) 若各期环境扰动跨期条件独立, 在设计 D_T 下平均估计量的方差为:

$$\text{Var}(\bar{\hat{R}}_T | n_T) = \frac{v_R}{T} + \frac{A}{B}, \quad (15)$$

其中 $A = \bar{R} + \rho(\bar{R}^2 + v_R)/k$ 。当总预算 B 固定时, 比较不同设计 D_T , 增加观测期数 T (相应减少每期样本 $m = B/T$) 严格单调降低估计方差;

(ii) 若各期环境扰动存在一阶自回归自相关 $\text{Cov}(R_t, R_{t+s} | n_T) = v_R r^{|s|}$ ($0 \leq r < 1$), 则有限期数 T 下的精确方差为:

$$\text{Var}(\bar{\hat{R}}_T | n_T) = \frac{v_R}{T} \left[\frac{1+r}{1-r} - \frac{2r(1-r^T)}{T(1-r)^2} \right] + \frac{A}{B}, \quad (16)$$

在大期数极限 $T \gg 1$ 下, 其渐近形式可表示为有效独立期数近似:

$$\text{Var}(\bar{\hat{R}}_T | n_T) \approx \frac{v_R}{T_{\text{eff}}(T, r)} + \frac{A}{B}, \quad T_{\text{eff}}(T, r) \triangleq T \frac{1-r}{1+r}; \quad (17)$$

(iii) **离散可行设计集合**: 当要求各期风险集相同且为正整数 ($n_T \in \mathbb{N}_+$), 并精确用尽总预算 B 时, 设计者仅能在如下离散可行集合中比较期数:

$$\mathcal{T}(B, \rho) \triangleq \left\{ T \in \mathbb{N}_+ : \frac{B}{\rho T} \in \mathbb{N}_+ \right\}. \quad (18)$$

若 $B/\rho \in \mathbb{N}_+$, 可行期数为其正整数因子集合; 不等式 $T \leq \lfloor B/\rho \rfloor$ 仅是属于该集合的必要条件而非充分条件。

证明. 由全方差公式, 由于给定环境序列后分支与抽样过程条件独立, 平均估计量的方差严格分解为环境项与抽样项:

$$\begin{aligned}\text{Var}(\widehat{R}_T | n_T) &= \frac{1}{T^2} \text{Var} \left(\sum_{t=1}^T R_t \middle| n_T \right) + \frac{1}{T^2} \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[\text{Var}(\widehat{R}_t | n_T, R_t) | n_T] \\ &= \frac{1}{T^2} \text{Var} \left(\sum_{t=1}^T R_t \middle| n_T \right) + \frac{A}{T(\rho n_T)}.\end{aligned}$$

将 $n_T = B/(\rho T)$ 代入抽样项, 即得 $\rho n_T = B/T$, 从而第二项恒为 A/B 。在环境跨期独立假定下, 第一项化为 v_R/T , 相加直接得式 (15)。若各期环境扰动存在一阶自回归自相关, 利用平稳协方差双重求和展开:

$$\text{Var} \left(\sum_{t=1}^T R_t \middle| n_T \right) = T v_R + 2 v_R \sum_{s=1}^{T-1} (T-s) r^s = v_R T \left[\frac{1+r}{1-r} - \frac{2r(1-r^T)}{T(1-r)^2} \right].$$

除以 T^2 即得式 (16)。当 $T \gg 1$ 时忽略 $O(1/T^2)$ 项, 直接得到有效期数近似。最后由 $n_T = B/(\rho T) \in \mathbb{N}_+$ 即得式 (18)。□

注记 4 (理论决策含义与真实传播限制). 式 (15) 表明: 在本文限定的固定总预算、单地区、无外部环境协变量的理想设计中, 病例规模相关方差项 A/B 保持不变; 唯有通过在可行集合 $\mathcal{T}(B, \rho)$ 内增加观测期数 T , 方能以 $O(1/T)$ 削减共同环境随机性 v_R 。需要强调的是, 真实疫情的时间序列具有自回归传染卷积, 感染风险集往往受上一期影响而无法由设计者任意自由拆分。因此, 该命题给出的是理想设计对比下的数理边界。

推论 1 (成本与预算约束下的最优监测规模). 设监测系统在每个观测期存在固定的系统运转与维持成本 $c_0 > 0$, 每捕获上报一个病例的边际成本为 $c_1 > 0$ (若按所覆盖的目标人群计算人均监测成本 c'_1 , 则对应 $c_1 = c'_1/\rho$)。在总成本预算 $B = T(c_0 + c_1 m)$ 约束下, 假设设计者沿扩大基数 n 的方向 (即固定报告率 ρ , 变动风险集 n) 寻求连续近似期数 $T \geq 1$ 与单期期望报告规模 m 的最优组合以最小化跨期估计方差 $\text{Var}(\widehat{R}_T) = \frac{v_R}{T} + \frac{A}{Tm}$ 。为保证期数 $T \geq 1$ 的可行性, 要求单期规模满足可行上界 $m \leq (B - c_0)/c_1$ 。代入 $T = \frac{B}{c_0 + c_1 m}$, 方差目标函数正比于 $v_R(c_0 + c_1 m) \left(1 + \frac{m_\times}{m}\right)$ 。对其关于 m 求一阶导并令其为零, 由于二阶导数 $\frac{2c_0 A}{m^3} > 0$ 恒正, 在满足可行边界条件下, 唯一内部最优单期规模由下式给出:

$$m^* = \sqrt{\frac{c_0}{c_1} \cdot \frac{A}{v_R}} = \sqrt{\frac{c_0}{c_1} m_\times}. \quad (19)$$

注意: 若由内部一阶条件求出的规模超出可行上界 (即 $\sqrt{\frac{c_0}{c_1} m_\times} > \frac{B-c_0}{c_1}$), 则由凸函数的单调性, 最优配置取可行域边界角点解 $m^* = \frac{B-c_0}{c_1}$ (对应最低期数 $T = 1$)。命题 4 中无固定成本的纯总人数预算 $B = Tm$ 恰对应 $c_0 = 0$ 的特例, 此时 $m^* \rightarrow 0$, 即若无单期固定维持开销, 资源配置应极端倾向于拉长期数 T ; 推论 1 则刻画了存在固定周期开销时的现实权衡。若环境扰动在固定观测周期长度下存在一阶自回归自相关 $\text{Cov}(R_t, R_{t+s}) = v_R r^{|s|}$ ($r > 0$), 大期数极限下有效环境方差由 v_R 增大为 $v_{\text{eff}} \approx v_R \frac{1+r}{1-r}$, 使得环境随机性相较抽样误差更为棘手, 最优单期规模将相应调整为 $m_{\text{AR}}^* \approx \sqrt{\frac{c_0}{c_1} m_\times \frac{1-r}{1+r}} < m^*$, 表明强自相关环境下应将更多预算向拉长观测期数 T 倾斜。

注记 5 (经典两阶段抽样同构与运筹设计含义). 在理论同构层面, 推论 1 中的方差 $\frac{v_R}{T} + \frac{A}{Tm}$ 与总成本 $T(c_0 + c_1 m)$ 结构, 在数理形式上与经典调查抽样理论中两阶段抽样 (*Two-stage Sampling*) 的最优次级样本量配置模型 (36, 第 10 章) 优美对应——时间观测期 T 对应初级抽样单元数, 单期报告病例 m 对应每单元次级样本量。推论 1 的理论推进在于将这一经典抽样设计赋予传染病监测运筹解释, 并引入 $AR(1)$ 自相关修正拓展至动态时序。在设计含义上, 最优单期规模 m^* 对未知参数对 (v_R, A) 的依赖完全通过交叉点比值 $m_\times$ 充分降维体现; 数值上, m^* 恰为成本比与方差交叉点的几何平均值。例如依据呼吸道传染病唯象示例参数设定 (*Illustrative Scenario*) 导出理论交叉点约 21–49 例 ($m_\times \approx 21.3 \sim 49.3$; 参数设定详见第 5.2 节): 若固定边际成本比 $c_0/c_1 = 10$, 则最优配置规模区间为 $m^* \approx 14.6 \sim 22.2$; 若 $c_0/c_1 = 100$, 则对应 $m^* \approx 46.1 \sim 70.2$ 。这澄清了交叉点 $m_\times$ 本身是方差等权位置, 而真实决策的最优规模取决于成本结构。

3.6 当期超临界增长判定检验与离散检出功效

利用式 (4) 的精确负二项条件分布, 可直接建立基准模型下判定当期超临界增长 ($R_t > 1$) 的统计检验。考虑单侧假设检验问题:

$$H_0 : R_t \leq 1 \quad \text{对} \quad H_1 : R_t > 1. \quad (20)$$

命题 5 (当期超临界增长判定检验与精确离散功效). 在已知 (n, ρ, k) 的基准模型下:

- (i) 负二项分布族关于充分统计量 C_t 具有单调似然比 (*Monotone Likelihood Ratio, MLR*) 性质; 采用拒绝域 $\{C_t \geq c_\alpha\}$ 的非随机化上尾检验, 在复合原假设 $H_0 : R_t \leq 1$ 下将第一类错误率严格控制在 α 以内: 由 *MLR*, 尾部概率 $\Pr_{R_t}(C_t \geq c)$ 关于 R_t 单调不减, 故 $\sup_{R_t \leq 1} \Pr_{R_t}(C_t \geq c_\alpha) = \Pr_{R_t=1}(C_t \geq c_\alpha)$, 即水平控制在边界点 $R_t = 1$ 处取上确界, 只需在该点校准即可。离散临界值 $c_\alpha \in \mathbb{N}$ 取使边界处超额拒绝概率受控的最小整数:

$$c_\alpha = \min \left\{ c \in \mathbb{N} : \Pr_{R_t=1}(C_t \geq c) \leq \alpha \right\}; \quad (21)$$

- (ii) 对于任意给定的备择增长强度 $R_t = 1 + \delta$ ($\delta > 0$), 该非随机化检验的理论检出功效由下式精确给出:

$$\pi(n, \delta) \triangleq \Pr_{R_t=1+\delta}(C_t \geq c_\alpha) = 1 - F_{\text{NB}}\left(c_\alpha - 1; nk, \frac{k}{k + \rho(1 + \delta)}\right), \quad (22)$$

其中 $F_{\text{NB}}(x; r, p) = \sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\Gamma(j+r)}{j! \Gamma(r)} p^r (1-p)^j$ 为负二项累积分布函数。

证明. (i) 给定 (n, ρ, k) , C_t 的分布族为以 R_t 为参数的负二项族, 其概率质量函数 $\Pr(C_t = j) \propto (k/(k + \rho R_t))^{nk} (1 - p^*)^j$ 。对任意 $R'_t > R_t$, 似然比 $\Pr_{R'_t}(j)/\Pr_{R_t}(j)$ 关于 j 严格单调递增 (分子分母中 $(1 - p^*)^j$ 的指数律比较, p^* 随 R_t 递减), 故该族关于充分统计量 C_t 具有单调似然比。由 *MLR* 性质, 尾部概率 $\Pr_{R_t}(C_t \geq c)$ 关于 R_t 单调不减, 因此 $\sup_{R_t \leq 1} \Pr_{R_t}(C_t \geq c_\alpha) = \Pr_{R_t=1}(C_t \geq c_\alpha) \leq \alpha$, 即拒绝域 $\{C_t \geq c_\alpha\}$ 在复合原假设下严格控制水平。(ii) 在备择 $R_t = 1 + \delta$ 处直接计算同一拒绝域的概率即得式 (22)。另注: 固定 (ρ, k) 时, 整数临界值 $c_\alpha(n)$ 作为 n 的函数单调不减 (随 nk 呈现离散阶梯状跳变), 但由于离散阶梯跳跃, 实际检验水平与统计功效 $\pi(n, \delta)$ 关于 n 呈现局部的非单调锯齿形波动, 故满足特定功效要求的最小样本量确定必须逐点枚举而非单纯二分搜索。 $\square$

注记 6 (检验性质与多期反弹识别的区别). 由于报告计数的非负离散性, 非随机化检验在大多数有限样本下实际水平 $\Pr_{R_t=1}(C_t \geq c_\alpha)$ 严格小于名义水平 α (呈现保守性)。更重要的是, 命题 5 判定的是**当期单代传播参数是否超临界** ($R_t > 1$)。这与流行病学中基于多期时序轨迹的“疫情反弹实时识别 (*Resurgence Detection*)”具有本质区别 [18]: 后者需要推断系统状态由亚临界向超临界的跨期转变过程, 而单期检验仅评估当期横截面信号的统计显著性。

3.7 预测误差的条件分解: 仅报告数据可见时的严格形式

在现实流行病学监测中, 真实感染历史不可见, 决策者仅能依据报告历史 $\mathcal{F}_t^C$ 进行前瞻推断。引入更新过程描述跨周感染压力:

$$\Lambda_{t+1} = \sum_{s=1}^S w_s I_{t+1-s}, \quad \sum_{s=1}^S w_s = 1. \quad (23)$$

假设在给定潜变量与报告历史下满足:

$$\mathbb{E}[I_{t+1} \mid \Lambda_{t+1}, R_{t+1}, \mathcal{F}_t^C] = \Lambda_{t+1} R_{t+1}. \quad (24)$$

并且, 在给定当期真实感染数 I_{t+1} 条件下, 报告抽样过程 $C_{t+1} \mid I_{t+1} \sim \text{Binomial}(I_{t+1}, \rho)$ 条件独立于既往报告历史 $\mathcal{F}_t^C$ 。

命题 6 (真实感染与报告病例的单步预测方差分解). 基于截至第 t 期的报告信息集 $\mathcal{F}_t^C$, 未来真实感染数 I_{t+1} 的预测方差严格满足全方差恒等式:

$$\text{Var}(I_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C) = \text{Var}(\Lambda_{t+1} R_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C) + \mathbb{E}[\text{Var}(I_{t+1} \mid \Lambda_{t+1}, R_{t+1}, \mathcal{F}_t^C) \mid \mathcal{F}_t^C]. \quad (25)$$

在上述二项观测假定下, 未来报告病例数 C_{t+1} 的预测方差严格由下式给出:

$$\text{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C) = \rho(1 - \rho) \mathbb{E}[I_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C] + \rho^2 \text{Var}(I_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C). \quad (26)$$

证明. 对 I_{t+1} 以 (Λ_{t+1}, R_{t+1}) 为条件应用全方差公式, 即得式 (25)。对于报告病例 C_{t+1} , 以 I_{t+1} 为条件应用全方差公式:

$$\text{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C) = \mathbb{E}[\text{Var}(C_{t+1} \mid I_{t+1}, \mathcal{F}_t^C) \mid \mathcal{F}_t^C] + \text{Var}(\mathbb{E}[C_{t+1} \mid I_{t+1}, \mathcal{F}_t^C] \mid \mathcal{F}_t^C).$$

由条件独立假定 $C_{t+1} \mid (I_{t+1}, \mathcal{F}_t^C) \sim \text{Binomial}(I_{t+1}, \rho)$, 有 $\text{Var}(C_{t+1} \mid I_{t+1}, \mathcal{F}_t^C) = I_{t+1} \rho(1 - \rho)$ 与 $\mathbb{E}[C_{t+1} \mid I_{t+1}, \mathcal{F}_t^C] = \rho I_{t+1}$, 代入即得式 (26)。□

4 数值模拟评估

为检验上述解析推导的有限样本表现及其对时间序列预测的参照价值, 本节设计两组模拟实验: 其一评估命题 5 导出的增长判定检验有限样本功效与正态近似失效; 其二在时间序列更新过程中清晰剥离事后代理增长统计量与事前单步病例预测的误差演变机制, 评估其如何向参照曲线收敛。

4.1 当期超临界增长判定的有限样本检出功效与正态近似失效

在传染病预警实践中，分析人员常使用基于渐近正态近似的 Wald 检验 $Z = (\hat{R}_t - 1)/\sqrt{V_0}$ 来判定当期传播是否超临界 ($R_t > 1$)，其中零假设下的理论方差为 $V_0 = \frac{1}{\rho n} + \frac{1}{kn}$ ，拒绝域为 $\{Z \geq z_{1-\alpha}\}$ 。命题 5 指出，报告病例遵循离散负二项分布，因此正态连续近似在低病例规模或高超传播环境下可能出现严重扭曲。

本文在名义水平 $\alpha = 0.05$ 、固定报告率 $\rho = 0.25$ 下，针对不同超传播参数 $k \in \{0.1, 0.35, 1.0\}$ 与期望报告规模 $m \in [5, 600]$ 进行 30,000 次蒙特卡洛抽样检验，结果如图 2 所示。

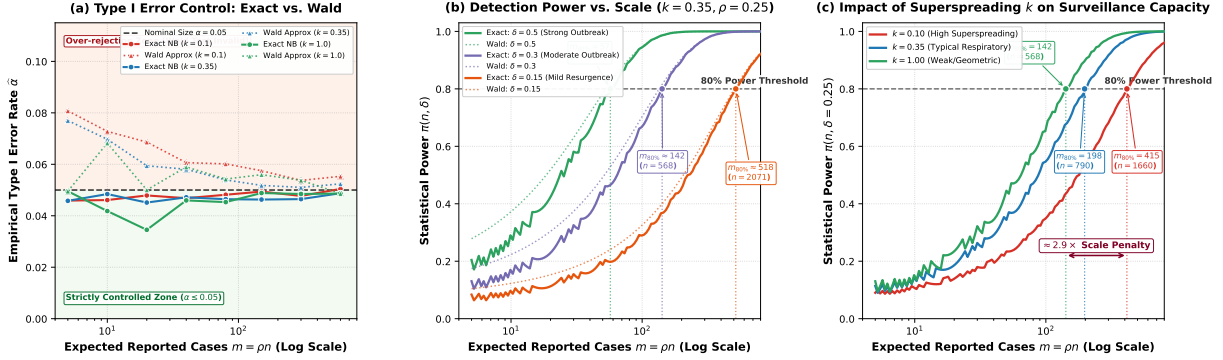


图 2: 早期暴发检验尺度效应、功效边界与超传播惩罚。(a) 一类错误率控制: 渐近正态 Wald 检验 (虚线) 在低病例规模 ($m < 40$) 且严重超传播 ($k = 0.1$) 时经验一类错误率最高达 8.1% ($m = 5$, 30,000 次模拟), 系统性高于名义水平; 离散精确负二项检验 (实线) 在全样本网格上严格控制错误率低于 0.05。(b) 检出功效曲线随备择强度 $\delta = R_t - 1$ 的响应: 在 $k = 0.35$ 时, 达到 80% 功效所需的期望报告规模由微弱暴发 $\delta = 0.15$ 的 $m = 517.8$ ($n = 2071$) 急剧下降至 $\delta = 0.30$ 的 $m = 142.0$ ($n = 568$) 与 $\delta = 0.50$ 的 $m = 57.2$ ($n = 229$)。(c) 个体超传播离散度 k 的杠杆惩罚: 在 $\delta = 0.25$ 增长强度下, 达到 80% 检出功效所需的期望病例数从低异质性 $k = 1.0$ 的 $m = 142.0$ ($n = 568$) 急剧上升至严重超传播 $k = 0.1$ 的 $m = 415.0$ ($n = 1660$), 规模需求放大了近 3 倍。标称显著性水平 $\alpha = 0.05$, 基准报告率 $\rho = 0.25$ 。

模拟结果展现了三项重要发现:

- 第一类错误率失真:** 如图 2(a) 所示, 渐近 Wald 检验在低病例规模且超传播 ($k \leq 0.35$) 时失效 ($k = 1.0$ 的最小规模点经验水平 0.0495, 未过检)。在网格内最小规模 $m = 5$ 、 $k = 0.1$ 处, Wald 检验的经验一类错误率达到最高的 8.1% (30,000 次模拟), 约为名义水平 0.05 的 1.6 倍, 且全低规模段 ($m < 40$) 系统性过检, 极易引发虚假超临界报警; 相比之下, 命题 5 导出的离散精确临界值 c_α 在所有规模下均保守且严格受控于 0.05 以下。
- 检出功效对备择强度的非线性响应:** 如图 2(b) 所示, 在固定 $k = 0.35$ 时, 达到 80% 可靠功效所需的期望报告病例数随信号强度急剧下降: 微弱增长 ($\delta = 0.15$) 需要 $m = 517.8$ 例; 中度增长 ($\delta = 0.30$) 降至 $m = 142.0$ 例; 显著增长 ($\delta = 0.50$) 仅需 $m = 57.2$ 例即可可靠检出。
- 超传播对样本需求的放大机制:** 如图 2(c) 所示, 在相同增长信号 ($\delta = 0.25$) 下, 个体异质性越强 (k 越小), 曲线右移越显著。从低异质性 $k = 1.0$ 到强超传播 $k = 0.1$, m 需求放大了近 3 倍。

4.2 时间序列更新过程：事后增长统计量与事前单步病例预测

在时间序列动态更新过程中，记预测时已知的历史报告加权和为：

$$D_t \triangleq \sum_{s=1}^S w_s C_{t+1-s}. \quad (27)$$

当历史连续多周报告为零时，分母 $D_t = 0$ 导致比值无定义。在统计评估中，本文明确规定评估仅在具备活跃历史信息的周 ($D_t > 0$) 上进行，**不做任何其他数据依赖的剔除**。实测表明，在每组 150 条轨迹、每条 26 个预测起点（共 3,900 个评价点）中：在 $m = 6$ 组中仅剔除 3 周（发生率 0.077%，有效周数 3,897）；在 $m = 12$ 组仅剔除 1 周（发生率 0.026%，有效周数 3,899）；在 $m \geq 25$ 的所有规模组中剔除数为 0（有效周数均为 3,900）。另需说明：仿真中当期真实感染数被强制下界 $I_t \geq 1$ （代码中的 $\max(1, I)$ 截断），该下界仅在极小规模的低概率周生效，防止更新过程因零感染而永久熄灭；它对小规模端的误差有轻微向下偏置。需要特别指明：图 3 横轴的 m 表示每条轨迹的初始期望报告规模；由于在 $\bar{R} = 1.15$ 下后续规模随传播过程动态变化，理论曲线仅作按初始规模排列的对比参照。

在此活跃周子集上，严格区分两个评价对象：

- (1) **事后代理增长统计量误差**：在 $t+1$ 期报告 C_{t+1} 实际观测后，事后计算比值 $G_{t+1} \triangleq C_{t+1}/D_t$ 。其相对基础水平的均方误差定义为 $\mathbb{E}[(G_{t+1} - \bar{R})^2 \mid D_t > 0]$ 。
- (2) **事前单步病例预测相对均方误差 (Ex-ante Forecasting RelMSE)**：在 t 时刻，决策者仅依据截至 t 期的报告历史，对下一期报告病例数作出预测： $\hat{C}_{t+1|t} \triangleq \bar{R}D_t$ 。当 C_{t+1} 实际出现后，计算相对均方预测误差：

$$\text{RelMSE}(m) \triangleq \mathbb{E} \left[\left(\frac{C_{t+1} - \hat{C}_{t+1|t}}{\hat{C}_{t+1|t}} \right)^2 \mid D_t > 0 \right] = \frac{1}{\bar{R}^2} \mathbb{E} [(G_{t+1} - \bar{R})^2 \mid D_t > 0]. \quad (28)$$

式 (28) 表明：在相同的活跃周样本上，事前病例预测相对误差与事后增长统计量误差严格相差常数因子 $1/\bar{R}^2$ 。因此，二者在每一规模组的相对翻倍削减率中常数因子完全相消，经验降幅严格同一。

然而，这一代数等价性并不证明它们在理论上精确等于单代理想基准。设 $\mu_{t+1|t} \triangleq \mathbb{E}[C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C]$ 与 $\sigma_{t+1|t}^2 \triangleq \text{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t^C)$ ，在活跃周上有严格条件分解：

$$\mathbb{E} [(G_{t+1} - \bar{R})^2 \mid D_t > 0] = \mathbb{E} \left[\frac{\sigma_{t+1|t}^2}{D_t^2} + \left(\frac{\mu_{t+1|t}}{D_t} - \bar{R} \right)^2 \mid D_t > 0 \right]. \quad (29)$$

式 (29) 清楚揭示了更新过程较之单代基准所增加的两个关键机制：其一是用报告历史代理真实感染压力导致的**预测偏差项** $(\mu_{t+1|t}/D_t - \bar{R})^2$ ；其二是随机分母 D_t 对条件方差的**倒数二次方重新加权**。

因此，由已知真实风险集单代模型导出的 $V(m) = v_R + A/m$ 以及经缩放的参照曲线 $(v_R + A/m)/\bar{R}^2$ ，**仅作为参照基准而非更新过程预测误差的精确定理**。二者的渐近环境底板分别为 $v_R = 0.040$ 与 $v_R/\bar{R}^2 = 0.0302$ 。

数值实验结果展现了三项关键发现：

1. **事后统计量与参照曲线的对照**：如图 3(a) 所示，事后代理增长统计量叠合了式 (29) 中的预测偏差与随机分母波动，其随规模衰减的方向与单代参照曲线 $v_R + A/m$ 一致，但幅度

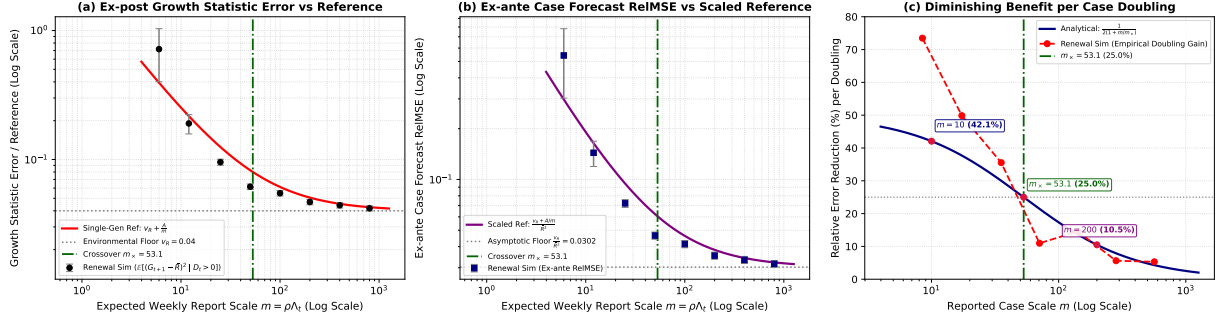


图 3: 更新过程时序卷积下事后增长统计量与事前单步病例预测误差。(a) 事后代理增长统计量均方误差 (黑色散点带 95% 置信区间) 与单代已知基准参照曲线 $V(m) = v_R + A/m$ (红实线, 其中 $A = 2.1232, v_R = 0.04$) 的对照; (b) 事前单步病例预测相对均方误差 (蓝色方块带 95% 置信区间) 与缩放参照曲线 $\frac{v_R + A/m}{R^2}$ (紫实线): $m \geq 25$ 段贴合 (参照的 0.75–0.98 倍), $m = 6$ 处为参照的 1.82 倍; (c) 病例规模每翻一倍所带来的相对误差削减百分比: 红圈为更新过程经验翻倍降幅 (事后统计量与事前预测经验降幅严格同一; $m < 12$ 段经验降幅系统性高于解析式, 首点 $m = 6 \rightarrow 12$ 的 73.5% 超出纵轴范围), 深蓝实线为单代参照曲线的解析公式 $\frac{1}{2(1+m/m_\times)}$ 。在 $m = 10$ 时, 参照翻倍削减为 42.1%; 在交叉点 $m_\times = 53.1$ 处为 25.0%; 越过交叉点后, 在 $m = 200$ 时边际削减迅速衰减至 10.5%。(样本说明: 每规模组共 150 条轨迹 $\times$ 26 个预测起点 = 3,900 点; $m = 6$ 组剔除 $D_t = 0$ 者 3 点, 有效 3,897 点; $m = 12$ 组剔除 1 点, 有效 3,899 点; $m \geq 25$ 各组有效点均为 3,900 点)。

分两段: 在中大规模段 ($m \geq 25$) 经验误差平滑趋向环境方差底板 $v_R = 0.040$, 与参照曲线贴合; 在极小规模段 ($m = 6$), 完整活跃周样本 (不做任何数据依赖剔除) 的经验均方误差为 0.718, 明显高于单代参照值 0.394 (相对损失口径为 0.543 对 0.298) ——更新过程的重尾偏差在小规模端被随机分母二次放大, **经验误差并未贴合参照曲线**, 这是单代基准在极小规模不适用的直接证据, 而非噪声。 $m = 12$ 时两者已接近 (0.190 对 0.217)。

2. **事前预测相对误差的严格对应:** 如图 3(b) 所示, 在 t 时刻给出的病例预测相对均方误差 (由代数恒等式与第 1 项只差常数 $1/\bar{R}^2$) 在 $m \geq 25$ 段为缩放参照曲线 $\frac{v_R + A/m}{R^2}$ 的 0.75–0.98 倍并渐近收敛于 $v_R/\bar{R}^2 = 0.0302$; $m = 6$ 处为参照的 1.82 倍 (0.543 对 0.298), 与第 1 项的小规模端偏离同源。
3. **边际削减收益的定量衰减规律:** 针对解析参照曲线 $V(m) = v_R + A/m$, 病例规模翻倍时的相对方差下降比例严格由下式给出:

$$\frac{V(m) - V(2m)}{V(m)} = \frac{1}{2(1 + m/m_\times)}. \quad (30)$$

如图 3(c) 所示, 在 $m_\times \approx 53.1$ 下, 当 $m = 10$ 时, 规模翻倍可降低约 42.1% 的解析方差; 越过交叉点 $m_\times = 53.1$ (此处理论边际收益为 25.0%) 后, 当 $m = 200$ 时, 病例规模再翻倍仅能带来约 10.5% 的方差削减。这印证了本文的核心直觉: **越过交叉点后, 扩大病例捕获依然能边际改善预测, 但由于环境扰动占主导, 其改善速率急剧放缓。**

4.3 数值实验复现规格与参数说明

为确保所有模拟数值与图表的高度可复现性, 本节列明复现规格:

- (a) **软件包与离散分布参数化**：全部算法基于 Python 3.10 与 `scipy.stats` 实现。负二项分布采用标准形式 $NB(r, p)$ ，其中在条件均值 $\mu = \rho n R$ 与离散参数 k 下，参数映射为 $r = nk, p = \frac{k}{k + \rho R}$ 。累积尾概率由生存函数 `stats.nbinom.sf(c - 1, r, p)` 计算。
- (b) **图 2 离散功效与样本量枚举规则**：随机数种子设定为 20260924。对给定 $(k, \rho, \alpha = 0.05)$ ，临界值 c_α 通过整数搜索使零假设生存概率首次不超过 α 。在备择假设 $R_t = 1 + \delta$ 下，自 $n = 1$ 起以步长 1 递增枚举整数 n ，取首次满足功效 $\pi(n, \delta) \geq 0.80$ 的最小整数 n ，并换算为期望报告规模 $m = \rho n$ 。
- (c) **图 3 更新过程仿真参数与分母**：随机数种子设定为 20260925。感染间隔采用 4 周离散核 $w = (0.45, 0.35, 0.15, 0.05)$ ，环境扰动采用 Gamma 分布采样，均值为 $\bar{R} = 1.15$ ，方差为 $v_R = 0.04$ 。每规模组评估 150 条轨迹，时间跨度 $T = 30$ （前 4 周作为启动核，预测评估周为 $t = 4$ 至 29 共 26 周），总评价周数分母为 3,900。

5 实证检验：全美流感住院监测数据（2020–2026）

为对本文提出的理论方差结构、饱和交叉点 $m_\times$ 、报告杠杆冲击以及反证边界提供真实流行病学监测环境下的检验，本节利用全美疾控中心国家医疗保健安全网（CDC NHSN）周度流感住院报告数据开展系统实证。

5.1 数据源、制度分段与数据预处理

数据来自全美各州及华盛顿特区医院向 CDC NHSN 上报的周度实验室确诊新发流感住院人数 [37]（Total Influenza Admissions）及各州周度医院报告覆盖率（字段名 Percent Hospitals Reporting Influenza Admissions）。该住院指标系全美 CDC FluSight 自 2021–22 赛季起确立的核心基准预测目标（参见 Mathis et al. [31] 针对全美 26 个前瞻预测团队的评估），具备坚实的公共卫生实战代表性。样本时间跨越 2020 年 8 月至 2026 年 9 月，涵盖 50 个州及华盛顿特区共 16,218 个州–周观测（其中 504 个州–周的住院数缺失按 0 例处理：P1 期 468 个、P2 期 36 个；在制度切换期“未填报”与“零住院”不能等同，该处理主要影响 P2 期，见第 5.5 节的解读边界）。样本筛选采用单一口径： $D_t \geq 5$ 的活跃周阈值，得 10,303 个州–周有效样本；本文第 5.2–5.6 节的全部主分析、稳健性与滚动核验均基于该口径，不另设覆盖率门槛（避免系统性别除低覆盖观测）。在此口径下三个报告制度阶段的医院平均填报覆盖率分别为 91.1%、54.6% 与 91.8%，自愿过渡期的覆盖率断崖式跌落构成本文考察报告率冲击的主要制度变异来源。

报告制度三阶段划分：该监测系统在样本期内经历了三次具有政策调整特征的制度切换：

- (1) **前过渡高覆盖期（数据起点 2020 年 10 月至 2024 年 4 月 30 日，共 184 个有效周、 $N = 6,009$ ）**：该时段合并了两个制度子段——2020 年 10 月至 2022 年 9 月的大流行早期高强度上报（ $N = 2,627$ ，平均覆盖率 87.8%）与 2022 年 10 月 NHSN 法定强制上报起的法定强制段（ $N = 3,382$ ，平均覆盖率 93.7%），两子段合计平均覆盖率 91.1%（中位数 92.3%）；第 5.5 节的离散度对照将以法定强制段单列报告；
- (2) **第二阶段（自愿过渡期，2024 年 5 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，26 个有效周、 $N = 420$ ）**：强制令随紧急状态解除到期，医院转为自愿填报，各州平均报告覆盖率断崖式跌落至 54.6%（中位数 45.7%）；

(3) **第三阶段 (CMS 新规重制期, 2024 年 11 月 1 日起至样本终点 2026 年 9 月初, 96 个有效周、 $N = 3,874$)**: 美国医疗保险与医疗补助服务中心 (CMS) 将呼吸道传染病数据上报重新作为医保定点医院资质条件, 各州报告覆盖率迅速恢复至 91.8% (中位数 93.2%)。

状态空间设定与观测对象界定: 在离散周度时间序列中, 取滞后权重向量 $w = (0.65, 0.25, 0.10)$ (滞后 1、2、3 周, 平均回溯延迟为 $\sum_{s=1}^3 sw_s = 1.45$ 周, 约 10.2 天) 构建各州第 t 周的历史有效输入压力:

$$D_{j,t} = \sum_{s=1}^3 w_s C_{j,t+1-s}. \quad (31)$$

这里的 w 为**经验滞后暴露权重 (Empirical Lagged Exposure Weights)**: 其平均回溯 10.2 天符合流感从暴露感染、发病就医到收治入院并录入系统的临床与填报特征时间尺度, 使 $G_{j,t+1} = C_{j,t+1}/D_{j,t}$ 成为住院维度增长态势的平滑经验代理变量 (Proxy of Hospitalization Growth)。为严格检验实证结论对加权方案的敏感性, 本文在数据流程中对不同滞后核规格重新执行全套筛选与拟合 (见表 1): 原权重下有效样本 $N = 1,267$, $b = 2.2434$ (95% CI [1.5019, 3.0161]), $m_x = 22.65$; 三周等权平移 $w = (1/3, 1/3, 1/3)$ 下 $N = 1,240$, $b = 1.9262$ (95% CI [1.0706, 2.8074]), $m_x = 12.64$; 单周直接滞后 $w = (1, 0, 0)$ 下 $N = 1,290$, $b = 3.1337$ (95% CI [2.2031, 4.0668]), $m_x = 45.96$ 。核验结果表明: 在所有滞后规格下, 规模效应斜率 b 均稳健显著为正 (Bootstrap 95% CI 严格排除零点, 且 1,500 次重抽中无一次为负); 但经验收益拐点对回溯窗口具有实质敏感性 (在 12.64 至 45.96 例/周之间移动), 回溯时滞越短, 未平滑的单期代理噪声越大, 抵消噪声所需的规模相应增大, 故经验拐点应被视作与平滑方案绑定的量级参考而非刚性点位。当 $D_{j,t} \geq 5$ 时进入有效推断样本集 (单一活跃周口径, 不设覆盖率门槛, 理由见第 5.1 节)。

表 1: 不同滞后暴露权重设定下流行初期仿射模型的敏感性检验

加权设定方案	有效样本 N	阶段均值 $\bar{R}_{\text{early}}$	斜率 b	州聚类 95% CI	截距 a	经验收益拐点 m_x
原复合权重 (0.65, 0.25, 0.10)	1267	1.6706	2.2434	[1.5019, 3.0161]	0.0991	22.65
三周等权平移 (1/3, 1/3, 1/3)	1240	1.9929	1.9262	[1.0706, 2.8074]	0.1524	12.64
单周直接滞后 (1.0, 0.0, 0.0)	1290	1.4802	3.1337	[2.2031, 4.0668]	0.0682	45.96

注: 各规格均在对应滞后权重构造的 $D_{j,t} \geq 5$ 下重新筛选有效样本并执行 FGLS 拟合, CI 由 1,500 次州聚类 Bootstrap 给出。

阶段条件化预测基准与识别限定: 本节在评估预测误差时, 采用阶段条件化基准设定 $\hat{C}_{j,t+1|t} \triangleq \bar{R}_{\text{phase}} D_{j,t}$, 评分口径取相对尺度均方误差——相对误差评分在传染病预测评估中具有避免大流行周主导加权的光照尺度优势 [34]——在控制跨期趋势参数变化的同等基准下, 估计病例捕获规模 D_t 与相对预测误差的条件关联。医院维度的填报覆盖率 (比例) 可视为理论中报告率杠杆 ρ 在制度层面的宏观经验代理指标, 2024 年的制度切换由此构成命题 3 的天然对照场景, 其解释边界在第 5.5 节结合季节性子样本进一步校准。

5.2 检验一: 流行初期波段的方差衰减与经验收益放缓平台

按照第 2 节关于基准模型适用边界的定义, 本文在三个流感季节中提取**流行初期上升波段 (Early Growth Phase)**: 2022–2023 季的 10 月 8 日至 11 月 26 日; 2023–2024 季的 10 月 14 日至 12 月 16 日; 2024–2025 季的 11 月 9 日至 1 月 18 日。在这些波段内, 人群对当年毒株的

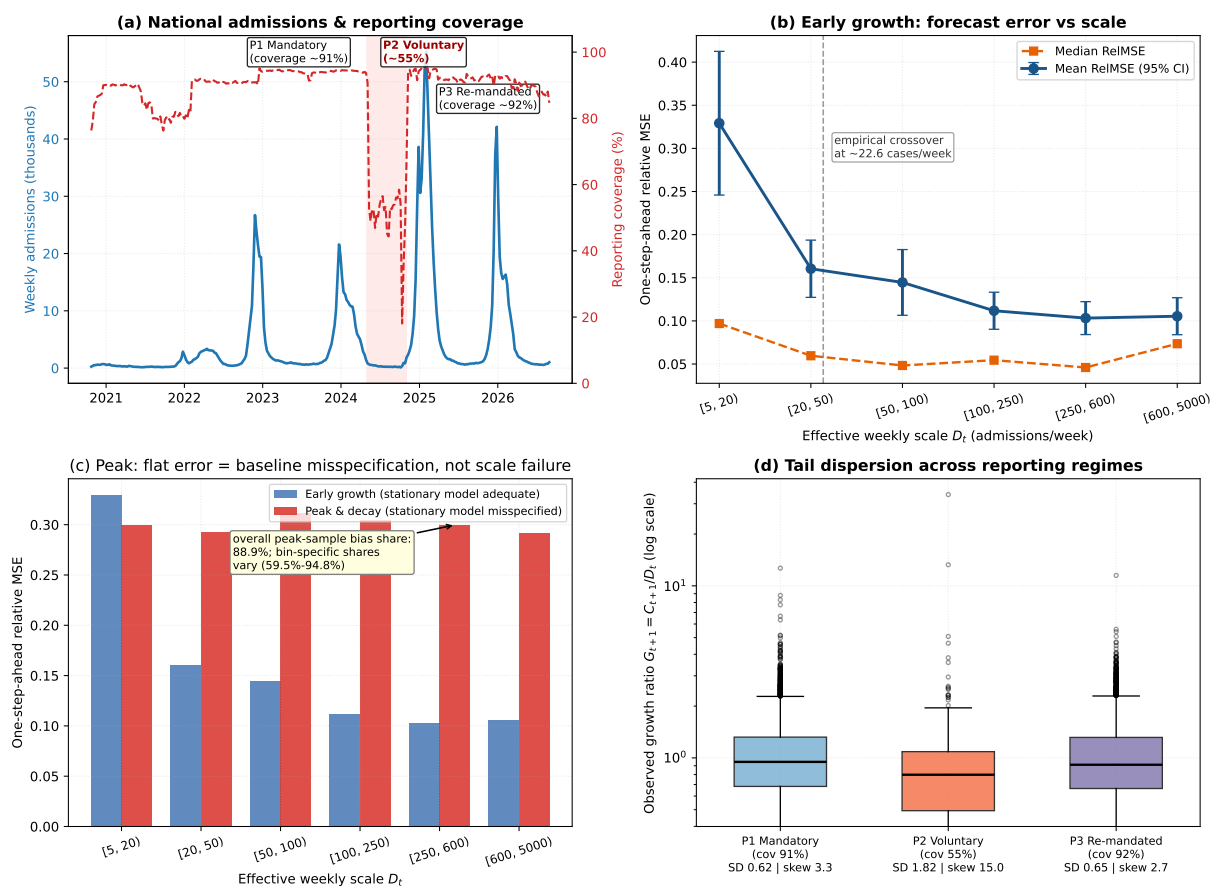


图 4: 全美流感住院真实数据经验拟合、平稳性失效与监测体制冲击。(a) 全美周度流感住院总人数 (蓝实线, 左轴) 与各州医院平均填报覆盖率 (红虚线, 右轴) 演变, 阴影区域标示 2024 年 5–11 月报告覆盖率骤降的自愿过渡期; (b) 流行初期上升波段中, 单步预测相对均方误差随每周病例捕获规模 D_t 的仿射衰减关系 (蓝圆点为经验均值与 95% CI, 橙方块为中位数), 误差在 $D_t \in [50, 250]$ 区间快速下降后平稳收敛至尺度不变量底板平台 (对应经验损失截距 $a = 0.0991$ 与均值 0.103), 灰色虚线标示经验收益拐点 22.6; (c) 达峰与回落期: 以流行初期估计的平稳基准 $\bar{R}_{\text{early}} = 1.6706$ 预测全部阶段时, 达峰与回落期 (红柱) 的总误差在所有规模组恒定处于 0.292–0.312 区间, 看似不再随 D_t 增大而下降; 但达峰期总体样本的均值偏移项占总损失 88.9% (0.267; 各规模箱占比 59.5%–94.8% 不等), 控制基准偏移后规模相关方差项仍显著为正, 证实失效的是跨期平稳基准假定而非病例规模本身; (d) 报告制度切换下观测增长率的尾部离散度 (对数轴箱线图, 含离群点): 自愿填报期标准差由 0.620 (法定强制子段) 升至 1.823 (扩张 194%), 偏度升至 14.98, 恢复强制后回落至 0.649 与 2.68; 主体分位距基本不变 (图中箱体宽度相近), 扩张集中于右尾离群点。实证基于全美 51 个辖区 CDC NHSN 2020–2026 年 16,218 个州-周有效住院监测观测。

自发防护行为尚未全面激活，公共卫生干预尚未强力介入，传播环境相对平稳。此阶段有效样本 ($N = 1267$) 平均增长率为 $\bar{R}_{\text{early}} = 1.6706$ (标准差 0.7116)。**口径声明：**本节主分析以该阶段的 $\bar{R}_{\text{early}}$ 为基准，属于**回顾性的阶段条件误差分析**——其目的是在受控的同等基准下检验误差随规模的衰减形态，而非声称该基准在波段内每个时点均可实时获得。严格的滚动起点预测（每个 t 仅用其前数据估计基准）在第 5.3 节单独报告，作为对规模效应结论的事前口径核验。

表 2 报告了各规模分组下**回顾性阶段条件基准下的单步相对平方误差**的经验统计量。为考虑同州跨周的时间相关性与组内聚类不确定性，表中同时给出常规 SEM 与按州 (State) 聚类的稳健标准误 (Cluster-robust SE)；本文的区间推断一律以州聚类 95% 置信区间为准。

表 2: 全美流感住院流行初期波段单步预测误差随周捕获规模的分组统计

每周有效规模 D_t	样本数 N	相对均方误差	中位数	普通 SEM	州聚类 SE	州聚类 95% 置信区间
[5, 20)	319	0.3292	0.0969	0.0425	0.0437	[0.2435, 0.4149]
[20, 50)	297	0.1605	0.0596	0.0169	0.0189	[0.1235, 0.1974]
[50, 100)	187	0.1446	0.0483	0.0194	0.0198	[0.1057, 0.1835]
[100, 250)	220	0.1118	0.0545	0.0110	0.0114	[0.0895, 0.1341]
[250, 600)	152	0.1032	0.0460	0.0097	0.0133	[0.0771, 0.1293]
[600, 5000)	92	0.1054	0.0735	0.0109	0.0146	[0.0769, 0.1340]

实证数据呈现出与理论命题 2 高度吻合的边际衰减特征。为使检验贴合理论的函数形式，本文不做分箱均值的粗略目视比较，而是按式 (7) 重写为 $v_R + A/m$ 后的形状，直接对原始观测估计仿射模型：

$$\mathbb{E} \left[\left(\frac{G_{t+1} - \bar{R}_{\text{early}}}{\bar{R}_{\text{early}}} \right)^2 \middle| D_t \right] = a + \frac{b}{D_t}, \quad (32)$$

其中 a 为**经验损失曲线的尺度不变量底板 (Scale-invariant Floor)**——与病例规模无关的渐近系统性误差项；按式 (29) 的更新过程代数，该项同时整合了宏观环境随机性 $v_R/\bar{R}^2$ 与未观测感染压力 Λ 的代理不确定性贡献；经验拟合值 0.0991 高于纯环境贡献的参数空间隐含值 (约 0.014–0.029)，差额与代理变量不确定性相容； b 为**经验规模相关项**；比值 b/a 对应理论交叉点 $m_\times$ 的经验对应物，直接标定了**监测规模的经验收益拐点 (Surveillance Efficiency Crossover)**，本文以下简称为**经验收益拐点**。估计采用一阶可行广义最小二乘 (FGLS)：由 OLS 起步，以拟合值平方的倒数为权重迭代至收敛，以应对相对均方误差的强异方差。标准误与置信区间由按州聚类的 cluster bootstrap 给出 (1,500 次重抽)。

主拟合结果与经验收益拐点：仿射模型估计给出规模相关方差项 $b = 2.2434$ ，按州聚类的 bootstrap 95% 置信区间为 [1.5019, 3.0161]，1,500 次重抽样中无一次出现 $b \leq 0$ 。这与式 (7) 中病例规模相关方差项 A/m 的递减形态相容。从极小规模 [5, 20) (平均 RelMSE = 0.3292) 扩大至 [20, 50) (0.1605)，经验相对均方误差下降了 **51.3%**；即使采用州聚类 95% 置信区间，[5, 20) 的下界 (0.2435) 与 [20, 50) 的上界 (0.1974) 仍严格分离。拟合截距给出 $a = 0.0991$ (95% CI [0.0841, 0.1173])，为与规模无关的经验损失截距拟合值，对应样本内已实现的大规模观测相对误差水平 (依第 6.2 节局限性分析，其数值同时包含了未观测感染压力的代理不确定性，不能单独识别为孤立的环境方差)；由 $m_\times^{\text{emp}} = b/a$ 得经验收益拐点 22.6 (95% CI [13.7, 33.7]) 例/周。十分位组均值拟合给出与基准一致的 22.6；但剔除损失最大的 1% 观测后交叉点左移至 10.6，而在

各事前滚动规格下位于 22.5 ~ 42.7 区间，表明该值对尾部处理和窗口设定有敏感性，应视为量级估计而非点位识别。分箱计算 loss 的方差-均值比可见， $\text{Var}(L)/\mathbb{E}[L]^2$ 从 [5, 20] 箱的 5.32 整体下降至 [600, 5000] 箱的 0.99，超额离散随规模扩大而收缩，为 FGLS 采用 $1/\hat{\mu}^2$ 权重提供了依据。为检验基准估计不确定性与跨州同周时间相关性的潜在影响，本文分别执行了两种单向聚类敏感性重抽：其一为在 cluster bootstrap 每次重抽中对样本均值执行内生重估计（Endogenous re-estimation），所得 b 的 95% CI 为 [1.5170, 2.9807]；其二为按观测周进行时间维度聚类重抽以检验同周外生冲击，所得 b 的 95% CI 为 [1.4728, 3.1191]。在两种单向聚类敏感性分析下，置信区间下界均稳健大于 1.47 且 1,500 次重抽无一为负，有力支持了规模效应为正的基本结论。

滞后工具变量规格敏感性检验： 针对 D_t 与 C_{t+1} 潜在共享报告扰动的问题，本文进一步以滞后 3–5 周报告序列另行构造的工具规模 D_t^{iv} 进行两阶段最小二乘（2SLS）规格敏感性对照。须预先澄清：在非实验宏观监测数据中，滞后住院规模与当期规模客观上共享疫情波段相位、人群行为惯性与报告时序结构，排他性假设（Exclusion Restriction）难以在理论上绝对保证；因此，此处的 2SLS 对照不作为严格因果识别，仅定位为**滞后工具规格下的方向性敏感性检验**，旨在核验规模项为正的发现是否对特定同期测度敏感。在全初期波段汇集样本（有效样本 $N = 1,051$ ）中，以全阶段均值 $\bar{R}_{\text{early}} = 1.6706$ 归一化时，第二阶段 b 的估计为 2.5305 ($a = 0.0812$)，高于同一样本 OLS 的 1.3525；若以该子样本自身均值 (1.6266) 归一化则给出 $b = 2.8501$ ($a = 0.0807$ ，对应 OLS 为 1.4581)。第一阶段未聚类 F 统计量达 1147.1，按州聚类的稳健 F 统计量为 312.9（远超强相关性门槛）。为避免跨年际波段相位干扰，更将 2SLS 限定在各个流感季初期波段内部独立运行：2022–23 季 ($N = 273$) 未聚类 $F = 277.4$ （聚类稳健 $F = 94.5$ ）， $b_{\text{iv}} = 3.2787$ (OLS: 1.8865)；2023–24 季 ($N = 358$) 未聚类 $F = 464.8$ （聚类稳健 $F = 119.4$ ）， $b_{\text{iv}} = 2.1867$ (OLS: 1.6760)；2024–25 季 ($N = 420$) 未聚类 $F = 503.3$ （聚类稳健 $F = 76.8$ ）， $b_{\text{iv}} = 3.6131$ (OLS: 1.8295)。在每一个独立季节内部，第一阶段稳健 F 统计量均在 75 以上；按州聚类的 10,000 次 bootstrap 检验下各季节 $b_{\text{iv}} > 0$ 均保持统计显著；虽然单季点估计均表现为 $b_{\text{iv}} > b_{\text{ols}}$ ，但差值 ($b_{\text{iv}} - b_{\text{ols}}$) 的 95% 置信区间在 2022–23 季 ($[-0.15, 3.89]$) 与 2023–24 季 ($[-0.55, 1.74]$) 跨越零，在 2024–25 季表现为临界为正 ($[0.01, 3.47]$ ，bootstrap 单侧比例为 0.025；若经 Bonferroni 族一类错误率多重校正，在 5% 水平下不显著)；而在全初期波段汇集样本中，该差值稳健排除零点（子样本均值归一化下差值为 1.3921，95% CI 为 $[0.43, 2.41]$ ，bootstrap 单侧比例为 0.0014）。这一对照证实：在采用滞后报告序列作为替代性工具变量的不同模型规格下，斜率项为正的方向与统计显著性依然保持高度稳健，规模效应的存在性不依赖于特定同期测度；但鉴于排除限制未经验证，不能据此将点估计差异解释为已严格识别的测量误差偏倚修正量。需强调： $m_{\times}^{\text{emp}}$ 定义在**住院维度的周捕获规模** D_t 上，而理论交叉点 $m_{\times} = \frac{\bar{R} + \rho(\bar{R}^2 + v_R)/k}{v_R}$ 定义在微观期望报告病例数 $m = \rho n$ 上，两者并非同一量。为进行唯象情景对照，本文设定唯象示例参数设定（Illustrative Scenario）：以初期平均 $\bar{R}_{\text{early}} \approx 1.67$ 、超传播示例取值 $k \in [0.2, 0.5]$ （参见 Lloyd-Smith et al. [1] 异质性传播框架）、每例有症状感染的住院比例数量级 $\rho \in [0.0056, 0.021]$ （基于 Zhou et al. [35] 报告的人群年化住院负担点估计约 63.5/10 万人·年，除以 Tokars et al. [38] 估算的季节有症状感染侵袭率 3.0%–11.3% 折算），以及环境波动参数 $v_R \in [0.04, 0.08]$ 为代表，理论公式导出约 21–49 例 ($m_{\times} \approx 21.3 \sim 49.3$)。换算至未归一化绝对方差水平，经验拟合给出的规模无关项与规模相关项分别约为 $a \cdot \bar{R}_{\text{early}}^2 \approx 0.28$ 与 $b \cdot \bar{R}_{\text{early}}^2 \approx 6.3$ ，其绝对水平均高于纯抽样与环境理论设定（与宏观经验监测中包含代理变量噪声与时序卷积等额外波动相容），但两者的比值（经验收益拐

点 $m_x^{\text{emp}} = b/a = 22.6$ 与理论交叉点 $A/v_R \approx 21 \sim 49$ 在数量级上保持了一致与相容；该对照属唯象情景展示，重在比值形态的一致性，不应解读为微观参数的直接识别。

5.3 竞争基准对照与事前滚动核验

为回应仅评估单一阶段常数基准的局限性，本文进一步构建了两类具备竞争性的事前预测基线：其一是基于 Cori et al. [10] 滑动窗口更新过程的时变再生数预测 $\hat{C}_{t+1|t}^{\text{Cori}} = \hat{R}_t^{\text{Cori}} D_t$ （分别取 1 周、2 周与 3 周滑动窗 τ ）；其二是经典时间序列朴素平移基准 $\hat{C}_{t+1|t} = C_t$ 。在流行初期波段上，各基准的事前单步相对预测均方误差见表 3。结果展现出三项清晰特征：(1) 全体均值上，2 周窗与 3 周窗 Cori 基线的 RelMSE 分别为 0.2876 与 0.2490，中位数为 0.0658 与 0.0626，性能远优于朴素平移基准（均值 0.6367，中位数 0.1732）；(2) 关键在于分规模表现：在所有更新过程基准中，预测误差在 $D_t \leq 100$ 内随每周病例规模快速下降，越过百例量级后趋于平缓（约 0.087–0.098），进入收益放缓的经验底板平台；(3) 特别在大规模段（ $D_t \geq 100$ ），2 周与 3 周 Cori 基线的平均相对均方误差（约 0.087–0.098）甚至略低于常数阶段均值（0.103–0.112），原因在于时变参数能更好适应局部流行波动的拐点；但在小规模段（ $[5, 20)$ ），滑动窗口估计 R_t 自身引入了显著的有限样本小计数估计方差，导致误差高于平稳基准。对 2 周与 3 周 Cori 基线误差进行仿射拟合，分别给出 $b = 6.0637$ （ $m_x = 74.7$ ）与 $b = 4.9836$ （ $m_x = 65.3$ ）。须指出评分尺度的敏感性：表 3 中基线相对均方误差采用各自预测值 $\hat{C}$ 归一化，该指标直观反映各模型自身的相对波动，但对预测值具有非对称敏感性（倾向于对预测值偏大的模型赋予较低相对惩罚）；若在相同的 1,244 个有效样本上换用以回顾性阶段均值为共同分母的归一化尺度（以消除分母差异并统一可比基准），Cori 2 周窗与朴素平移基线的整体相对均方误差分别收敛为 **0.2230** 与 **0.2738**（原自身尺度分别为 0.2876 与 0.6367）。分规模观察显示：在共同样本的小规模段（ $[5, 20)$ ），阶段均值基准（0.3275）显著优于时变更新基准（0.4149）与朴素预测（0.4951），证实有限样本小计数估计方差会放大时变参数的波动；在大规模段（ $[250, 600)$ 与 $[600, 5000)$ ），阶段均值（0.1032、0.1054）与朴素平移（0.1171、0.0642）表现出高度竞争力，反映出大规模下流感住院序列具有极强的短期自相关惯性；在大规模段误差不再呈现单调下降，而是进入基准依赖的平缓区间（约 0.064–0.131），证实规模收益放缓这一基本形态对归一化尺度的稳健性。这表明：无论采用回顾性阶段基准还是事前时变更新过程基准，预测误差均随每周病例规模呈现递减形态并在大规模段趋于平缓，而各基准的误差绝对水平与收益放缓的具体点位随基准构造方式与评价尺度而异。

事后选定初期波段内的滚动起点核验： 上述主分析属回顾性口径。为核验规模效应结论在事前信息集下是否保持，本文对初期波段（波段本身为事后指定）每个观测 t 改用**仅其前数据**估计的基准重算损失：全部历史扩张窗（ $N = 1267$ ）得 $b = 9.1579$ （聚类 bootstrap 95% CI [5.8168, 12.8750]）， $b/a = 22.5$ ；26 周滚动池（ $N = 1267$ ）得 $b = 9.4562$ （CI [6.7612, 12.8078]）， $b/a = 42.7$ ；逐州扩张窗（ $N = 1260$ ）得 $b = 13.2666$ （CI [9.1385, 18.2948]）， $b/a = 38.9$ ；三者的 a 分别为 0.4063、0.2217、0.3409。三种滚动规格下误差水平整体抬升（ a 从 0.099 升至 0.22–0.41）——回顾性基准确实偏乐观，其份额分解应理解为**同等基准下的机制拆解而非可实现的预测精度**，且份额结构本身随基准口径在 39%–55% 间移动：回顾口径 54.8%/45.2%、全部历史扩张窗 54.9%/45.1%、26 周滚动池 39.1%/60.9%、逐州扩张窗 41.3%/58.7%（与规模无关/规模份额）；但规模相关项在所有事前口径下均显著为正、分箱误差保持快速衰减并趋平缓，大规模端（ $D_t \geq 250$ ）实际观测的误差水平也稳定低于全体平均的四至六成。规模效应的存在性与方向经受住了事前信息集的

表 3: 不同预测基准在流行初期波段单步相对均方误差 (RelMSE) 的规模分箱对照

每周有效规模 D_t	样本数 N	阶段均值基准	Cori 2 周窗基线	Cori 3 周窗基线	朴素平移基线
[5, 20)	319	0.3292	0.6576	0.5606	1.2563
[20, 50)	297	0.1605	0.2576	0.2288	0.5528
[50, 100)	187	0.1446	0.2271	0.1680	0.5639
[100, 250)	220	0.1118	0.0903	0.0870	0.3999
[250, 600)	152	0.1032	0.0975	0.0903	0.2356
[600, 5000)	92	0.1054	0.0983	0.0982	0.1360
全体样本均值	1267	0.1813	0.2876	0.2490	0.6367
全体样本中位数	1267	0.0653	0.0658	0.0626	0.1732

注: Cori 2 周窗与 3 周窗基线因局部比值非正分别剔除 23 与 16 个无效点, 全体有效样本量分别为 1,244 与 1,251。

检验; 变化的只是误差的绝对水平与份额结构。

误差预算分解: 仿射拟合不仅给出参数, 还允许把初期波段的平均相对均方误差 (0.181) 直接分解为拟合值的代数分解份额: 与规模无关的拟合项 a 贡献 **54.6%**, 规模相关项 b/D_t 贡献 **45.1%**, 模型外残差不足 0.3%。作为对照, 样本中实际处于大规模端 ($D_t \geq 250$, 越过经验交叉点 22.6 一个量级, 共 244 个观测) 的组内平均相对均方误差为 0.104——与拟合截距 $a = 0.0991$ 数值一致 (该一致性仅表明截距对应样本内大规模观测的已实现水平, 不构成对其机制来源的识别), 即经验数据中已实现的大规模观测误差水平约为全体平均 (0.181) 的六成; 其余约五成半的误差份额落在与规模无关的拟合项上, 提示环境协变量采集与多期平滑是值得进一步评估的互补路径 (命题 4)。达峰期条件方差口径下的分解结构类似 (46.7% 对 55.6%)。这组份额结构给本文的核心问题提供了一个可操作的参照: 规模收益真实存在, 但在各规格下约四至五成半 (39%–55%) 的误差份额与规模无关, 监测资源的配置取决于当前所处份额结构, 而非无条件的“越多越好”。

5.4 检验二: 达峰与回落期——失效的是平稳基准而非病例规模

科学命题的成立必须伴随明确的证伪边界, 但证伪检验本身必须可解释。本文的反证检验采取如下口径: 用流行初期估计的平稳基准 $\bar{R}_{\text{early}}$ 去预测全部阶段的病例。此时总误差可分解为两部分: 其一是基准偏移造成的常数偏差 $(\bar{R}_{\text{early}} - \bar{R}_{\text{phase}})^2 / \bar{R}_{\text{early}}^2$, 它与病例规模无关; 其二是该阶段内部的条件方差, 只有后者才回答“规模是否还有用”。若只报告总误差, 则“误差不随规模下降”可能是常数偏差主导的平凡结果, 不构成对规模有效性的检验。因此下文两者分别报告。达峰与回落阶段定义为各流感季全国达峰周 (2022-12-03、2023-12-30、2025-02-08) 及其随后 7 周, 共 1220 个州-周。在此期间, 全美各州平均增长率骤降至 $\bar{R}_{\text{peak}} = 0.8075$ (标准差 0.3048), 远低于流行初期的 1.6706。

表 4 与图 4(c) 给出了该口径下的分组误差。

对比两个阶段可以发现强烈的非对称性:

- **总误差层面:** 以平稳基准预测时, 达峰与回落期的误差在所有规模组恒定处于 0.292–0.312, 从 [5, 20) 组的 0.2998 到 [600, 5000) 组的 0.2916 几乎没有下降;

表 4: 达峰与回落期: 以平稳基准 $\bar{R}_{\text{early}}$ 预测时的分组误差

每周有效规模 D_t	样本数 N	相对均方误差	中位数
[5, 20)	33	0.2998	0.2361
[20, 50)	140	0.2927	0.2591
[50, 100)	162	0.3120	0.3085
[100, 250)	312	0.3049	0.3005
[250, 600)	311	0.2998	0.2976
[600, 5000)	262	0.2916	0.2987

- **但这一平稳性主要是常数偏差所致:** 在达峰期总体样本的均值-方差分解中, 基准偏移项 $(\bar{R}_{\text{peak}} - \bar{R}_{\text{early}})^2 / \bar{R}_{\text{early}}^2 = 0.2669$, 占总体损失的 88.9%。须注意这是总体口径的份额: 按各箱自身均值计算的偏差占比随规模上升 ([5, 20) 箱 59.5% 至 [600, 5000) 箱 94.8%), 小规模箱的偏差占比明显更低、条件方差占比更高, 故总体份额不代表各规模箱具有相同的偏差结构;
- **条件方差层面:** 改用达峰期自身的均值 $\bar{R}_{\text{peak}}$ 作基准后, 仿射拟合给出 $a = 0.0665$ (95% CI [0.0467, 0.0897])、 $b = 7.9272$ (95% CI [5.4239, 11.2248]) ——达峰期内部规模相关项显著为正。但阶段间的 b 比较必须统一损失尺度: 本条的达峰期损失以 $\bar{R}_{\text{peak}} = 0.8075$ 归一化, 而初期损失以 $\bar{R}_{\text{early}} = 1.6706$ 归一化, 两个 b 不在同一分母上。表 5 报告三种口径下的阶段比较: 在共同分母 ($\bar{R}_{\text{early}}$) 与未归一化两种可比口径下, 达峰期的 b (1.8521 与 5.1690) 均低于初期 (2.2434 与 6.2611); 为使推断完整, 本文在同一样本、共同分母口径下估计了四种规格的两阶段斜率差: 分别 OLS (2.3049 对 1.3866, 差 -0.9183)、联合 OLS 交互项 (-0.9183 ; 按州聚类 bootstrap 95% CI $[-2.33, 0.59]$)、分别 FGLS (2.2434 对 1.8521, 差 -0.3913)、联合 FGLS 交互项 (-0.3913)。两种估计程序内, 联合交互项均精确等于分别拟合的斜率差 (代数恒等), 差异只发生在 OLS 与 FGLS 之间——源于 FGLS 迭代权重随拟合值重新估计。全部四种规格的置信判断一致: 阶段斜率差点估计为负但区间含零, 未发现达峰期斜率增强, 也不能断言其更低。共同支撑集 [50, 600) 上结论相同 (共同分母口径 1.6326 对 2.9264)。原稿若以各自归一化口径直接比较 (7.9272 对 2.2434) 会得出“达峰期规模项绝对量更高”的相反印象, 那是分母差异的伪象;

表 5: 两阶段规模相关项 b 的三口径比较

损失口径	初期 b	达峰期 b	回答的问题
未归一化 $(G - \bar{R}_{\text{phase}})^2$	6.2611	5.1690	增长代理的绝对误差规模
共同分母 $\bar{R}_{\text{early}}^2$ 归一化	2.2434	1.8521	同一相对尺度下的阶段差异
各阶段均值归一化	2.2434	7.9272	各阶段相对自身基准的误差

- **因此正确的反证结论是关于基准而非样本量:** 在疫情高峰与回落期, 人群行为改变、节假日填报积压及医疗系统挤兑使跨期平稳基准 $\bar{R}$ 不再适用, 单期预测的首要误差来源转为基准偏移, 这解释了平稳模型在达峰期近 88.9% 的总体误差贡献。但本文的检验**不支持**“达峰期病例规模不再有用”这一更强主张: 控制基准偏移后, 达峰期内部的规模相关项仍显著为正 ($b = 7.9272$, 95% CI [5.4239, 11.2248])。同时, 统一尺度后的比较表明达峰期的规模项**并不比初期更强** (表 5) ——规模在两阶段同样有用, 但未显示阶段间增强。实际含义

是：达峰期需要换用**非平稳状态模型或显式行为协变量**，而不是停止扩大病例捕获。

时变经验交叉点的探索性证据： 上述两阶段对比（初期 $b/a = 22.6$ 对达峰期 119.2）提示经验交叉点可能随疫情阶段移动。为考察这一点，本文对全部有效观测做 26 周滚动窗口的窗口条件化仿射拟合（窗口内以自身均值 $\bar{R}_w$ 为基准）。251 个窗口的经验交叉点中位数为 36.5 (IQR [14.2, 61.6])，量级与分段估计一致，但离季窗口的估计极不稳定（个别窗口逾千例）；须注意逐周滚动产生的高度重叠窗口使该 IQR 的有效样本量小于表观窗口数，区间解读应视为保守。为考察窗口内基准与窗口误差同源的影响，进一步改用**前一窗口的均值作滞后基准**重估（滞后只保证时间先后，不自动保证外生性）：流感季窗口中位数 19.7 对非流感季 47.9，与窗口内基准下的分离（20.4 对 46.9）基本一致，说明该阶段性分离并非窗口内基准机械压缩的产物。稳健的定性事实是：**经验交叉点不是常数**——在传播活跃期规模收益的边界更近、扩大捕获更早进入回报放缓区，而低发期则需要更大的规模才能逼近环境底板，为动态监测资源配置提供了直接可用的阶段信号。

5.5 检验三：报告制度切换对观测噪声的冲击（命题 3 的实证启示）

2024 年 5 月至 10 月的自愿填报过渡期为观察报告率波动下的噪声表现提供了现实场景。为避免系统性地剔除低覆盖率观测，本节的有效样本仅要求 $D_t \geq 5$ ，不对医院覆盖率设门槛。如图 4(d) 所示：

- 本文以**法定强制子段**（2022 年 10 月起， $N = 3,382$ ，覆盖率 93.7%）为主对照口径：其标准差 0.620、偏度 3.45，与前过渡高覆盖期全段（ $N = 6,009$ ，标准差 0.624、偏度 3.29）及早期高覆盖子段（标准差 0.628）几乎相同，说明早期子段不驱动该期离散度；
- 在第二阶段自愿填报期（ $N = 420$ ，平均覆盖率跌至 54.6%），观测增长率的标准差攀升至 **1.823**（较前过渡全段增加 **192.1%**，较法定强制子段增加 **193.8%**），偏度从 3.29 暴增至 **14.98**，最大值达到 33.9（为强制期的 2.7 倍）；四分位距则由 0.638 变为 0.594；
- 在第三阶段 CMS 恢复强制后（ $N = 3,874$ ，覆盖率回升至 91.8%），观测增长率的标准差迅速回落至 0.649，偏度回落至 2.68——与**法定强制子段**的 0.620/3.45 相比几乎完全恢复，且此对照两端（0.620 与 0.649）同为法定强制制度，阶段可比性最严格。

离散度指标的选择与解释边界： 自愿填报期观测增长率的离散度扩张并非在所有**稳健离散度指标上都成立**：标准差扩张 192.1%（法定强制口径下为 193.8%）、偏度扩张 355.3%，但四分位距（0.638 $\rightarrow$ 0.594）与中位绝对离差（0.298 $\rightarrow$ 0.299）基本不变。这说明覆盖率下降主要放大的是**分布的右尾与极端值**，而非主体分布的宽度。此外，自愿过渡期（5–10 月）恰逢流感夏季低发期，样本中仅 55 个州-周落在流感季；流感季子样本中自愿期标准差为 4.793、IQR 为 1.818，均高于强制期池（0.652 与 0.710）；但须指出该 55 个州-周全部落在 2024 年 10 月（2024–25 季起峰月，平均增长率 2.155，高于强制期流感季池的 1.14–1.23），对照的是疫情相位而非纯粹的制度差异，无法在同月内对齐，故此对照只作方向性参考。两个证据方向的一致性——全样本与流感季子样本（自愿期标准差 4.793 对强制期 0.652）同向放大，且尾部指标与主体指标明确分化——与**报告率冲击放大分布右尾**的理论机制方向相容；鉴于医院维度覆盖率并不等同于事件级二项报告概率、停止填报的医院可能非随机（规模、季节、住院结构皆可混杂），且自愿期与夏季低发期重叠，本节对比定位为与**漏报噪声机制相容的描述性证据**，而非制度冲击的因果检验。

5.6 检验四：空间跨区域汇聚的方差收益与异质性限制

最后，针对通过地理汇聚扩大基数 n 的效果，本文将 50 个州及华盛顿特区的数据按周加总，构建全美整体流感住院时间序列。在全美汇总序列的流行初期波段中，平均周捕获规模为 $D_t \approx 6662$ 例，单步预测相对均方误差骤降至 **0.0348**（中位数 0.0115， $N = 28$ ），在数值上低于任何单个大州所达到的经验平台（约 0.10，约降至三分之一；受限于全国初期有效观测 $N = 28$ ，此处作描述性量级比较）。全国汇总序列在该评分下误差较低这一事实，说明空间汇聚与更低的相对误差并存；将其归因于“各州未完全同步的局部环境扰动相互抵消”与命题 3 中“唯有扩大真实基数才能使各项方差同时衰减”的方向相容，但本对比未单独识别环境抵消、子代波动平均与其他汇总效应的相对贡献。这一量级差距同时刻画了空间汇聚的两端：国家层面误差约降至单州平台的三分之一；而属地化预警所需的州级参数异质性与达峰时间差，则界定了简单汇总的适用边界——这一对照为分级监测体系的设计提供了量化参照。

5.7 检验五：跨预测模型与跨病种大流行场景的扩展验证

为核验规模效应边际衰减形态在自设基准之外的适用边界，本文进一步引入两组外部真实场景数据开展扩展验证（结果汇总于表 6）：其一是 Mathis et al. [31] 披露的美国 CDC FluSight 2022–2023 季官方多模型前瞻集成预测（Flusight-ensemble）；其二是 Flaxman et al. [39] 公开的欧洲 11 国 COVID-19 早期大流行发病监测序列。

前瞻集成预警模型验证（FluSight 2022–2023）： 在 FluSight 真实前瞻预测中，自变量为集合模型发布的周度预期住院规模 $\hat{Y}_{j,t}$ 。在纯事前信息筛选口径下（ $\hat{Y}_{j,t} \geq 5$ ，排除全国与海外属地，50 州与华盛顿特区有效样本 $N = 1,177$ ），FGLS 拟合给出 $a = 0.1295$ （95% CI [0.1020, 0.1633]）， $b = 7.8045$ （州聚类 95% CI [5.3582, 10.5260]），经验收益拐点为 $m_{\times} = 60.28$ 例/周（全辖区口径下为 66.11，回顾性全样本下为 75.70）。尤为关键的是阶段均值-方差分解：在真实前瞻集成模型下，达峰转折期的相对偏差平方仅占总损失的 **15.5%**（上升期为 32.3%，回落期为 1.5%）。这一对比恰好揭示了复杂预测体系的演进价值：正文单代常数基准下达峰期 88.9% 的均值偏移，暴露了静态模型在流行拐点处的结构性失配；而自适应多模型前瞻集成则成功将该系统性偏差大幅压缩至 15.5%，实证解释了公共卫生决策在跨过规模拐点后转向集合预警的科学必要性。

跨病种大流行场景验证（欧洲 11 国 COVID-19）： 基于 Flaxman et al. [39] 官方公开的欧洲 11 国早期暴发序列（2020 年 2 月至 4 月 7 天平滑日度确诊规模），在纯事前历史规模有效样本（ $D_t \geq 5$ ， $N = 404$ ）下，拟合给出 $b = 33.9223$ （国家聚类 95% CI [14.6021, 74.9873]），经验收益拐点为 $m_{\times} = 124.7$ 例/天；在增长期样本（ $N = 318$ ）与截尾子样本（ $N = 307$ ）下， b 分别为 18.5337 与 12.7632（CI 均严格远离零点），对应拐点分别为 88.1 与 67.7 例/天。两组扩展场景共同证实：规模相关方差项 $b > 0$ 的边际衰减形态在不同病种与复杂前瞻模型中具有普遍生命力；但具体收益拐点在不同监测体系间存在预期的内生浮动，应视为量级参照而非跨病种刚性物理常数。

表 6: 跨预测模型与跨病种大流行场景扩展验证与敏感性结果

验证场景与数据集	筛选规则与样本口径	样本数 N	斜率 b	聚类 95% CI	截距 a	经验收益拐点 m_x
CDC FluSight 集成模型	州级纯事前筛选 ($\hat{Y} \geq 5$)	1177	7.8045	[5.3582, 10.5260]	0.1295	60.28
Mathis et al. [31]	全辖区事前筛选 (含全美汇总)	1203	8.0721	[5.5204, 10.7831]	0.1221	66.11
流感前瞻集成预测	州级回顾性对照 (含实际值 ≥ 5)	1137	8.5208	[5.7935, 11.4120]	0.1212	70.29
欧洲 11 国 COVID-19	纯事前历史规模 ($D_t \geq 5$)	404	33.9223	[14.6021, 74.9873]	0.2721	124.7
Flaxman et al. [39]	增长期全样本 (增长比 $g > 1.0$)	318	18.5337	[7.1333, 44.0963]	0.2104	88.1
早期大流行确诊序列	原截尾子样本 ($1.0 < g < 10.0$)	307	12.7632	[7.2466, 20.0068]	0.1886	67.7

注: 置信区间分别由 1,500 次按州 (FluSight) 和按国家 (COVID-19) 聚类的 Bootstrap 给出。

6 讨论与结论

6.1 机制讨论与理论对话

本文的研究为理解传染病监测中病例规模的推断价值提供了清晰的分析视角。既有前沿文献基于有效再生数推导出了 Fisher 信息下界随病例规模近似线性增长的标度律 [17, 18], 但这一极限主要是针对测量当期环境瞬时参数 R_t 成立的。本文的分析表明: 一旦推断目标切换为消除单周共同波动的跨期基础水平 $\bar{R}$, 共同环境随机性 v_R 便构成了单期横截面内仅凭病例聚合无法消除的方差成分; 由此导出的方差交叉点 m_x , 在数理结构上恰对应单期信度比 (方差成分分析中信号方差占总方差比例) 等于 0.5 的对称位置 [24, 25]。

在此基础上, 监测杠杆的非对称性 (命题 3) 阐明了公共卫生监测的资源分配逻辑: 在存在个体超传播的疾病中, 单纯提升报告率 ρ 存在单期饱和下界, 唯有扩大地理或人群覆盖基数 n 才能压制子代抽样波动。而在时间序列动态演化中, 达峰期实证表明所谓“样本量失效”在本质上是跨期平稳假定的失效 (总体常数偏差贡献达 88.9%); 当剥离均值漂移后, 规模相关项依然稳定发挥方差削减效应。这提示决策者在不同流行相位应采取差异化的应对策略: 在传播初期关注病例捕获规模以越过交叉点, 而在达峰拐点则应迅速引入非平稳状态空间滤波或显式行为协变量。

6.2 研究局限与证据分层

为确保科学结论的严谨性与审慎性, 本文对全部论断实施严格的证据分层:

- (1) **理论基准的条件性:** 命题 1–6 是在已知真实风险集 n 与报告率 ρ 的负二项分支–二项报告基准模型下建立的规范数理基准, 界定的是纯粹抽样机制下的物理参照线; 真实时间序列中由于更新卷积与分母随机波动, 经验规模斜率相较于单代静态参数可能存在时序重加权放大效应 (此推论宜作为假说理解)。
- (2) **经验截距的机制类比性:** 仿射拟合给出的经验截距 $a = 0.0991$ 对应样本内大规模观测已实现的相对误差水平, 其数值高于纯环境波动的理论隐含值。依更新过程展开代数, 该截距同时包含了未观测感染压力的代理不确定性, 本文明确将其定性为与规模无关的经验损失下限, 而非环境方差 v_R 的孤立参数识别。
- (3) **因果推断的解释边界:** 尽管季节内独立 2SLS 工具变量回归的第一阶段稳健 F 统计量 (均大于 75) 表明弱工具偏倚可忽略, 但非实验宏观监测数据的排除限制在理论上无法绝对保证; 同时, 自愿填报期覆盖率冲击与夏季低发期重叠, 相关对比定位为与二项抽稀机制相容的描述性证据。

6.3 结论

本文建立了一个分层随机推断框架，从理论与实证两个层面系统探讨了疫情监测中病例规模的推断收益边界。数理分析证明推断跨期基准水平时存在由环境方差决定的平滑交叉点，揭示了报告率与样本基数的非对称杠杆效应以及成本约束下的规模最优化权衡；全美 CDC NHSN 周度流感住院数据的实证分析与反证检验为该理论机制提供了相容的经验对照。研究表明规模收益真实存在但在越过数十例量级后呈现放缓，且在不同基准规格下约四至五成半（39%–55%）的误差份额落在与规模无关的拟合项上，为推动监测资源在扩大样本覆盖、环境协变量采集与多期时空平滑之间合理配置提供了量化理论参照。未来研究可进一步结合显式气象行为协变量与动态状态空间滤波，拓展多毒株共循环场景下的实时监测优化设计。

数据与代码可用性声明

本文实证所用的全美各州周度流感住院监测数据来源于美国疾病控制与预防中心国家医疗保健安全网（CDC NHSN）公开数据库 [37]（目录记录标识符 `ua7e-t2fy`），数据集访问日期为 2026 年 9 月 5 日，分析所用交付 CSV 数据文件的 SHA-256 校验和为：

`e48c2ea92e0beb552a6510b7b0c2fe7a7c9ea911cd27880169298c34de20c330`

为确保研究的完全透明与可复现性，本研究的全部仿真模拟脚本、计量实证分析代码、理论证明底稿及原始固化数据均已开源共享，访问地址为：<https://github.com/wangchi2068/case-count-inference-bottleneck>。

References

- [1] James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438(7066):355–359, 2005. doi: 10.1038/nature04153.
- [2] Akira Endo, Sam Abbott, Adam J Kucharski, and Sebastian Funk. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. *Wellcome Open Research*, 5:67, 2020. doi: 10.12688/wellcomeopenres.15842.3.
- [3] A Azmon, C Faes, and N Hens. On the estimation of the reproduction number based on misreported epidemic data. *Statistics in Medicine*, 33(7):1176–1192, 2014. doi: 10.1002/sim.6015.
- [4] Oliver Stoner, Theo Economou, and Gabriela Drummond Marques da Silva. A hierarchical framework for correcting under-reporting in count data. *Journal of the American Statistical Association*, 114(528):1481–1492, 2019. doi: 10.1080/01621459.2019.1573732.
- [5] David A Rasmussen, Oliver Ratmann, and Katia Koelle. Inference for nonlinear epidemiological models using genealogies and time series. *PLOS Computational Biology*, 7(8):e1002136, 2011. doi: 10.1371/journal.pcbi.1002136.
- [6] Benjamin D Dalziel, Stephen Kissler, Julia R Gog, Cécile Viboud, Ottar N Bjørnstad, C Jessica E Metcalf, and Bryan T Grenfell. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. *Science*, 362(6410):75–79, 2018. doi: 10.1126/science.aat6030.
- [7] Adam J Kucharski, Timothy W Russell, Charlie Diamond, Yang Liu, John Edmunds, Sebastian Funk, and Rosalind M Eggo. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5):553–558, 2020. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30144-4.

- [8] Jacco Wallinga and Peter Teunis. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures. *American Journal of Epidemiology*, 160(6):509–516, 2004. doi: 10.1093/aje/kwh255.
- [9] Christophe Fraser. Estimating individual and household reproduction numbers in an emerging epidemic. *PLOS ONE*, 2(8):e758, 2007. doi: 10.1371/journal.pone.0000758.
- [10] Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178(9):1505–1512, 2013. doi: 10.1093/aje/kwt133.
- [11] Robin N Thompson, J E Stockwin, R D van Gaalen, J A Polonsky, Z N Kamvar, P A Demarsh, E Dahlqvist, S Li, E Miguel, T Jombart, et al. Improved inference of time-varying reproduction numbers during infectious disease outbreaks. *Epidemics*, 29:100356, 2019. doi: 10.1016/j.epidem.2019.100356.
- [12] Katelyn M Gostic, Lauren McGough, Edward B Baskerville, Sam Abbott, Keya Joshi, Christine Tedijanto, Rebecca Kahn, Rene Niehus, James A Hay, Pablo M De Salazar, et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t . *PLOS Computational Biology*, 16(12):e1008409, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008409.
- [13] Nicholas Steyn, Kris V Parag, Robin N Thompson, and Christl A Donnelly. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. *Statistics in Medicine*, 44(18-19):e70204, 2025. doi: 10.1002/sim.70204.
- [14] Pierre Nouvellet, Anne Cori, Tini Garske, Isobel M Blake, Ilaria Dorigatti, Wes Hinsley, Thibaut Jombart, Harriet L Mills, Gemma Nedjati-Gilani, Maria D Van Kerkhove, Christophe Fraser, Christl A Donnelly, Neil M Ferguson, and Steven Riley. A simple approach to measure transmissibility and forecast incidence. *Epidemics*, 22:29–35, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2017.02.012.
- [15] Samir Bhatt, Neil Ferguson, Seth Flaxman, Axel Gandy, Swapnil Mishra, James A Scott, et al. Semi-mechanistic Bayesian modeling of COVID-19 with renewal processes. *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 186(4):601–615, 2023. doi: 10.1093/jrssa/qnad030.
- [16] Johannes Bracher and Leonhard Held. A marginal moment matching approach for fitting endemic-epidemic models to underreported disease surveillance counts. *Biometrics*, 77(4):1202–1214, 2021. doi: 10.1111/biom.13371.
- [17] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022. doi: 10.1038/s43588-022-00313-1.
- [18] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010004.
- [19] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02358-w.
- [20] Steinar Engen, Øyvind Bakke, and Aminul Islam. Demographic and environmental stochasticity—concepts and definitions. *Biometrics*, 54(3):840–846, 1998. doi: 10.2307/2533838.
- [21] Pejman Rohani, Matthew J Keeling, and Bryan T Grenfell. The interplay between determinism and stochasticity in childhood diseases. *The American Naturalist*, 159(5):469–481, 2002. doi: 10.1086/339467.
- [22] Carles Bretó, Daihai He, Edward L Ionides, and Aaron A King. Time series analysis via mechanistic models. *The Annals of Applied Statistics*, 3(1):319–348, 2009. doi: 10.1214/08-AOAS201.
- [23] Rachael Aber, Yanming Di, and Benjamin D Dalziel. Time-series modeling of epidemics in complex populations: Detecting changes in incidence volatility over time. *PLOS Computational Biology*, 21(7):e1012882, 2025. doi: 10.1371/journal.pcbi.1012882.
- [24] Wayne A Fuller. *Measurement Error Models*. John Wiley & Sons, New York, 1987. doi: 10.1002/9780470316665.
- [25] Raymond J Carroll, David Ruppert, Leonard A Stefanski, and Ciprian M Crainiceanu. *Measurement Error in Nonlinear Models: A Modern Perspective*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2nd edition, 2006. doi:

10.1201/9781420010138.

- [26] Geert Verbeke and Geert Molenberghs. *Linear Mixed Models for Longitudinal Data*. Springer, New York, 2000. doi: 10.1007/978-1-4419-0300-6.
- [27] Ben G Armstrong. Effect of measurement error on epidemiological studies of environmental and occupational exposures. *Occupational and Environmental Medicine*, 55(10):651–656, 1998. doi: 10.1136/oem.55.10.651.
- [28] Benjamin M Althouse, Samuel V Scarpino, Lauren Ancel Meyers, John W Ayers, M Bargsten, J Baumbach, et al. Enhancing disease surveillance with novel data streams: challenges and opportunities. *EPJ Data Science*, 4:17, 2015. doi: 10.1140/epjds/s13688-015-0054-0.
- [29] Nicholas G Reich, Craig J McGowan, Teresa K Yamana, Abhinav Tushar, Evan L Ray, Dave Osthus, Sasikiran Kandula, Logan C Brooks, Willow Crawford-Crudell, Graham Casey Gibson, Evan Moore, Rebecca Silva, Matthew Biggerstaff, Michael A Johansson, Roni Rosenfeld, and Jeffrey Shaman. Accuracy of real-time multi-model ensemble forecasts for seasonal influenza in the U.S. *PLOS Computational Biology*, 15(11):e1007486, 2019. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007486.
- [30] Matthew Biggerstaff, Michael A Johansson, David Alper, Logan C Brooks, Prithwish Chakraborty, David C Farrow, et al. Results from the second year of a collaborative effort to forecast influenza seasons in the United States. *Epidemics*, 24:26–33, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2018.02.003.
- [31] Shannon M Mathis, Alexander E Webber, Teresa M León, Eleanor L Murray, Monica Sun, Lauren A White, et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-50601-9.
- [32] Estee Y Cramer, Evan L Ray, Velma K Lopez, Johannes Bracher, Andrea Brennen, Alvaro J Castro Rivadeneira, Aaron Gerding, Tilmann Gneiting, Nicholas G Reich, et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(15):e2113561119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2113561119.
- [33] Evan L Ray, Logan C Brooks, Jacob Bien, Matthew Biggerstaff, Nikos I Bosse, Johannes Bracher, Estee Y Cramer, Sebastian Funk, Aaron Gerding, Michael A Johansson, et al. Comparing trained and untrained probabilistic ensemble forecasts of COVID-19 cases and deaths in the United States. *International Journal of Forecasting*, 39(3):1366–1383, 2023. doi: 10.1016/j.ijforecast.2022.06.005.
- [34] Nikos I Bosse, Sam Abbott, Anne Cori, Edwin van Leeuwen, Johannes Bracher, and Sebastian Funk. Scoring epidemiological forecasts on transformed scales. *PLOS Computational Biology*, 19(8):e1011393, 2023. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011393.
- [35] Hong Zhou, William W Thompson, Cécile G Viboud, Corinne M Ringholz, Po-Yung Cheng, Claudia Steiner, et al. Hospitalizations associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States, 1993–2008. *Clinical Infectious Diseases*, 54(10):1427–1436, 2012. doi: 10.1093/cid/cis211.
- [36] William G Cochran. *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1977.
- [37] Centers for Disease Control and Prevention. Weekly Hospital Respiratory Data (HRD) Metrics by Jurisdiction, National Healthcare Safety Network (NHSN). <https://data.cdc.gov/d/ua7e-t2fy>, 2026. CDC open-data catalogue record ua7e-t2fy. Accessed 2026-09-05.
- [38] Jerome I Tokars, Sonja J Olsen, and Carrie Reed. Seasonal incidence of symptomatic influenza in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 66(10):1511–1518, 2018. doi: 10.1093/cid/cix1060.
- [39] Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy, H Juliette T Unwin, Thomas A Mellan, Helen Coupland, Charles Whittaker, Harrison Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W Eaton, et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. *Nature*, 584(7820):257–261, 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2405-7.